ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

Elevance Health, Inc.

ELV · NYSE · ISIN US0367521038 · Health Care

Fecha de corte de los datos: **26 oct 2026** · Divisa: **USD** · Cifras en **millones**

Recomendación **Mantener**	Precio **439,95 USD**	Objetivo 12 m **464,78 USD**	Rentabilidad 12 m **+7,2 % (base +10,4 %)**
Valor intrínseco **441,18 USD · mercado 494,71**	Convicción **Media**	Capitalización **95.513 M**	EV/EBITDA próx. 12 m **11,6x**
Deuda neta aj. / EBITDA **2,7x**			

Nombre	**Elevance Health, Inc.**	Ticker / ISIN	**ELV / US0367521038**
Mercado	**NYSE**	Índice de referencia	**S&P 500**
Sector / industria	**Health Care / Managed Health Care**	Sede · fundación	**Indianápolis (Indiana) · 2004**
Empleados	**97.000**	Web	**elevancehealth.com**
Precio (fecha)	**439,95 (23 oct 2026)**	Rango 52 semanas	**274,84 – 450,69**
Acciones diluidas (M)	**217,1**	Free float	**99,8 %**
Capitalización	**95.513 M USD**	Valor empresa	**124.447 M USD**
Volumen medio diario	**≈ 468 M USD/día (1,15 M de acciones, 3 meses)**	Próximos resultados	**27 ene 2027**

Contenido

- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».

No constituye recomendación de inversión.

Síntesis y recomendación

Mantener · Convicción Media · Objetivo a 12 meses **464,78 USD** frente a 439,95 · Rentabilidad a 12 meses **+7,2 % (base +10,4 %)** · Valor intrínseco 441,18 USD · con la prima implícita del mercado: 494,71 (+12,4 %) · Alcista / bajista +18,3 % / -32,8 %

La recomendación y por qué. Mantener, con convicción media. El objetivo a 12 meses es de 464,78 USD frente a un precio de 439,95 (cierre del 23-oct-2026): una rentabilidad ponderada del +7,2 % con dividendo y del +10,4 % en el caso base, por debajo del 15 % y el 12 % que pide la compra. El valor intrínseco (441,18 USD) coincide con el precio y el objetivo medio de los analistas (481,48) queda algo por encima de nuestro base (478,62). La razón: el 3T26 confirma la recuperación, pero la subida del 27 % en el año ya la paga. La convicción es media porque las dos reglas coinciden y están lejos de sus umbrales; la subiría un precio por debajo de 409,59 USD o una guía de 2027 por encima de 31 USD de BPA ajustado con un ratio de prestaciones por debajo del 90 %.

Qué ha cambiado desde el 14-oct. El 3T26 batió (BPA ajustado de 6,99 USD frente a 4,71 de consenso, aunque 1,85 USD fueron no operativos), el ratio de prestaciones bajó 70 pb al 90,6 % y la guía de 2026 subió a ≥ 29,00 USD, con ≥ 12 % de crecimiento en 2027 sobre una base de 26,75 [4, 17]. El BPA ajustado de 2028e del caso base apenas cambia (33,47 USD frente a 33,55); el precio sube un 2,7 % (de 428,26 a 439,95). La señal pasa de Comprar a Mantener por una corrección de método: el informe anterior comparaba una historia del PER sobre el BPA contable (≈ 18-20x) con casos sobre el ajustado, lo que inflaba el múltiplo; con la misma base, la mediana de cinco años es 14,3x y la ponderada baja del 21,2 % al 7,2 %. El valor intrínseco baja de 444,43 a 441,18 USD.

El negocio. Segunda aseguradora de salud de EE. UU., con 44,9 M de afiliados y Carelon (farmacia y servicios) [4, 37]. ROIC del 11,3 % en 2025, 2,8 puntos por encima del WACC (8,54 %) y por debajo de los 5 que exigimos; el ROIC incremental de 2021-2025 es del 6,3 %. La calidad sostiene el crecimiento proyectado solo en parte: hay poder de precio (−70 pb de ratio con ingresos planos), pero pierde cuota por decisión propia en Medicare Advantage (−15,5 % de afiliados) y Medicaid, y las compras de 2024 aún no rinden [4].

Equipo y gobierno. Neutral. Tres subidas de guía en 2026 tras incumplir en 2024 y 2025; compras de la consejera delegada y del presidente en julio y una venta de 4,66 M del director financiero el 22-oct, sin plan 10b5-1 [4, 44].

Valoración. El DCF da 448,43 USD; los escenarios ponderados, 428,24; el PER de los comparables, 481,72, y la suma de partes, 396,67. El DCF inverso dice que el precio descuenta un crecimiento del 3,6 % anual (frente a nuestro 4,0 %) o un margen EBITDA final del 5,9 % (frente a nuestro 6,0 %): rinde un 8,7 % anual, casi nuestro coste de capital. A 14,4 veces el BPA ajustado de 2027e ya no hay descuento frente a su historia.

Riesgos y catalizadores. El ratio de prestaciones es la palanca: cada punto de margen EBITDA vale ≈ 125 USD, y el bajista (margen de 2025) lleva a 295,73 USD. Medicaid (requisitos de trabajo desde 2027), las tarifas de Medicare Advantage de 2028 (finales de enero) y la demanda del Departamento de Justicia son los riesgos abiertos [5]. Catalizador principal: resultados y guía de 2027 el 27-ene-2027.

Qué cambiaría la decisión. Compraríamos por debajo de 409,59 USD solo si además el ROIC recuperara 5 puntos sobre el WACC y la sostenibilidad pasara a «Sí»; venderíamos por encima de 523,36. Pasaríamos a Vender si el ratio de prestaciones de 2027 vuelve al 91 % o la guía de 2027 queda por debajo de 29 USD.

Resumen ejecutivo

Confianza: Media

Recomendación: Mantener · Convicción: Media · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **464,78 USD** (rentabilidad +7,2 % (base +10,4 %)) · Valor intrínseco: 441,18 USD (+0,3 % sobre 439,95) · con la prima implícita del mercado: 494,71 (+12,4 %)

Elevance es la mayor licenciataria de Blue Cross Blue Shield y la segunda aseguradora de salud de EE. UU.: 197.584 M USD de ingresos en 2025, 44,9 M de afiliados y negocios propios de farmacia y servicios (Carelon) que aportan cerca de la mitad del resultado operativo [1, 4]. Su modelo cobra primas antes de pagar y apenas invierte en activos, lo que dio un ROIC del 12-14 % en 2021-2024. En 2024-2025 el coste médico de Medicaid y Medicare Advantage subió más que las tarifas: el BPA ajustado cayó de 33,14 USD (2023) a 30,29 (2025) y la acción perdió la mitad [8, 48].

A 439,95 USD el precio descuenta la recuperación: un margen EBITDA final del 5,9 % frente al 6,0 % que proyectamos y un BPA ajustado que vuelve a crecer un 12 % en 2027. Cotiza a 14,4 veces ese beneficio, en su mediana de cinco años.

El mercado acierta en lo esencial. Nuestras cifras de 2027-2028 están cerca del consenso y el valor que sale de ellas (448,43 USD en el DCF, 441,18 en la síntesis) rodea el precio. Para invertir hay que creer que Medicaid sale del suelo de 2026 con los requisitos de trabajo en marcha y que el margen de Medicare Advantage sube al 3-5 %; es posible, pero ya está en el precio.

La decisión

Elemento de la decisión	Valor
Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA 2028e, ponderado 25/50/25)	464,78 USD
Bajista / base / alcista a 12 meses	11,5x × 26,23 = 301,65 · 14,3x × 33,47 = 478,62 · 16,1x × 37,28 = 600,21
Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)	7,2 % / 10,4 %
Regla de múltiplos aplicada	v3: base a mitad de camino hacia la mediana adelantada, sin alejarse del actual más de ×1,1; bajista mín. 5 a (adelantado) o base × 0,80; alcista techo base × 1,35 (selector de método: sin marcas: decide la v3)
Objetivo medio de los analistas (solo contraste)	481,48 (nuestro base -0,6 %)
Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)	441,18 USD
Potencial sobre el precio actual	0,3 %
Rentabilidad por dividendo ordinario	1,6 %
Rentabilidad total esperada a 12 meses	1,8 %
Escenario alcista / bajista	18,3 % / -32,8 %
Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)	0,56x
Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado	8,7 % frente a 8,5 % y 7,6 %
Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 7,6 %)	494,71 USD
Rentabilidad total esperada con la prima del mercado	14,0 %
Asimetría con la prima del mercado	1,70x
Regla absoluta (frente a su coste de capital)	Mantener
Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)	Mantener
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2032e) frente al previsto para su mercado	3,6 % frente a 5,7 %

Elemento de la decisión	Valor
¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?	En parte (3,5 % anual proyectado; sin inversión neta)
Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)	Mantener
Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)	Mantener
Convicción según los criterios (Mantener con las dos reglas de acuerdo y lejos de los umbrales)	Media

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

Acción	A qué precio
Comprar	Por debajo de 410,13 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco)
Mantener	Entre 410,13 y 524,05
Vender o reducir	Por encima de 524,05 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %)

Qué cambiaría la recomendación

- Si el precio cae por debajo de 409,59 USD con la sostenibilidad en «Sí» y el ROIC 5 puntos por encima del WACC, pasaríamos a Comprar.
- Si la guía de 2027 da un BPA ajustado por encima de 31 USD con el ratio de prestaciones por debajo del 90 %, revisaríamos el objetivo al alza.
- Si la guía de 2027 queda por debajo de 29 USD o el ratio de prestaciones de 2027 vuelve al 91 %, pasaríamos a Vender.
- Si el Departamento de Justicia impone un acuerdo superior a 2.000 M o cambios en la codificación de riesgo, revisaríamos a la baja.
- Si el precio supera 523,36 USD, venderíamos.

Dónde discrepamos del mercado

Lo que descuenta el precio.

Un margen EBITDA final del 5,9 % y un crecimiento del 3,6 % anual en 2027-2032: la guía de 2026, el +12 % de 2027 y una recuperación casi completa hacia nuestro 6,0 %. Los analistas van algo más allá: 14 de 22 recomiendan comprar con un objetivo medio de 481,48 USD [49].

Lo que creemos nosotros.

Coincidimos con la recuperación, pero no vemos rentabilidad suficiente: con un coste de capital del 8,54 % ya vale lo que cuesta. Nuestro objetivo a 12 meses (464,78 USD) aplica la mediana de cinco años del PER adelantado a nuestro BPA ajustado de 2028e.

Por qué podemos tener razón.

El 3T26 tiene una parte no repetible (1,85 USD por acción de beneficio no operativo) y el riesgo regulatorio de Medicaid y Medicare Advantage es mayor que cuando la acción cotizaba a 16 veces el beneficio adelantado (2021-2022). La beta de la acción (0,63) no lo recoge.



Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	448,43	+1,9 %	40 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	481,72	+9,5 %	15 %
Transacciones precedentes (no se usa)	736,00	+67,3 %	0 %
Suma de partes	396,67	-9,8 %	10 %
Escenarios ponderados	428,24	-2,7 %	35 %

A favor

- **Tercera subida de la guía**: BPA ajustado de 2026 de al menos 29,00 USD, desde 25,50 en enero [4].
- **2027 cuantificado**: al menos un 12 % de crecimiento sobre 26,75 USD (≥ 29,96) [4].
- **El ratio de prestaciones mejora**: 90,6 % en el 3T26, 70 pb menos que un año antes [4].
- **Caja**: flujo operativo de 7.512 M en nueve meses y recompras a 324,88 USD de media [5].
- **Con la prima del mercado** el valor sube a 494,71 USD y la rentabilidad al 14,0 %.

En contra

- **El precio ya paga la recuperación**: valor intrínseco de 441,18 USD, el precio de hoy.
- **ROIC solo 2,8 puntos sobre el WACC** y ROIC incremental del 6,3 %.
- **Batido de baja calidad**: 1,85 USD del BPA del 3T26 fueron no operativos [4].
- **Medicaid**: requisitos de trabajo desde 2027 y margen en su suelo [17].
- **Bajista profundo**: −32,8 % si el margen se queda en el de 2025.

Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

La tesis depende de que el ratio de prestaciones siga bajando por precios y no por reservas o renta de inversiones, con Medicaid saliendo del suelo de 2026 a pesar de los requisitos de trabajo. La señal de que no se cumple: una guía de 2027 por debajo de 29 USD de BPA ajustado (27-ene-2027) o un ratio de prestaciones del 1T27 peor que el del 1T26. La segunda condición es regulatoria: el aviso de tarifas de Medicare Advantage de 2028 (finales de enero) por encima del +2 %.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Nivel actual	Umbral de alerta	Por qué importa
Ratio de prestaciones	90,6 % (3T26)	> 91 % anual	Cada punto de margen EBITDA vale ≈ 125 USD por acción.
Guía de BPA ajustado de 2027	≥ 29,96 USD prometido	< 29 USD	Es la base del BPA de 2028e del objetivo.
Margen de Medicaid	Suelo en 2026 (objetivo 2-4 %)	Negativo en 2027	La mitad de la recuperación del margen depende de Medicaid.
Renta de inversiones trimestral	1.037 M (3T26)	< 600 M	Separa la mejora operativa de la financiera.
Aviso de tarifas de Medicare Advantage 2028	+2,48 % en 2027	< +2 %	El aviso de 2027 costó un −14,3 % en un día.

Datos clave

EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m	**11,8x / 11,6x**	PER últimos 12 m / próx. 12 m	**18,7x / 14,7x**
EV/EBIT últimos 12 m	**13,7x**		
EV/Ventas últimos 12 m	**0,63x**	Rentabilidad por FCF	**6,8 %**
Rentabilidad por dividendo	**1,6 %**	Crecimiento anual de ingresos (2021-2025)	**9,6 %**
Margen EBITDA últimos 12 m	**5,3 %**	ROIC último ejercicio	**11,3 %**
WACC	**8,5 %**	Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada)	**2,7x · 2,7x**
Gobierno (criterios cumplidos)	**10 de 13**		

Parte I — Negocio y sector

1. Historia e hitos

Confianza: Alta

Elevance Health nace en 2004 de la fusión de Anthem (Indiana) y WellPoint (California), las dos mayores licenciatarias de Blue Cross Blue Shield. Como WellPoint compró Amerigroup en 2012 (Medicaid) y volvió a llamarse Anthem en 2014; su intento de comprar Cigna (2015) lo bloquearon los tribunales en 2017. Desde 2017, con Gail Boudreaux de consejera delegada, ha añadido servicios: gestor de farmacia propio (IngenioRx, hoy CarelonRx, desde 2020), Beacon Health Options (salud conductual, 2020), MMM de Puerto Rico (2021), BioPlus (2023), Paragon y CareBridge (2024). En 2022 cambió el nombre a Elevance Health y agrupó los servicios en Carelon [1]. La lección de 2024-2026 es que la escala Blue no protegió el margen cuando Medicaid y Medicare Advantage subieron de coste más deprisa que las tarifas [4].

Año	Hito
2004	Fusión de Anthem (Indiana) y WellPoint (California), las dos mayores licenciatarias de Blue Cross Blue Shield.
2012	Compra de Amerigroup: entrada en Medicaid gestionado.
2017	Los tribunales bloquean la compra de Cigna; Gail Boudreaux, consejera delegada.
2020	Lanza su propio gestor de farmacia (IngenioRx, hoy CarelonRx) y compra Beacon Health Options.
2022	Cambia el nombre a Elevance Health; los servicios pasan a Carelon.
2024	Compra Paragon, CareBridge y Centers (4.809 M); el ratio de prestaciones sube al 88,5 % y el BPA ajustado cae por primera vez en una década.
2025	Ratio de prestaciones del 90,0 % y BPA ajustado de 30,29 USD frente a 33,14 en 2023.
2026	Aviso de CMS sobre datos de riesgo de Medicare Advantage (provisión de 935 M, 342 M pagados, caso cerrado sin sanciones en julio); salida de mercados de Medicare Advantage y Medicaid; guía de BPA ajustado subida tres veces, a al menos 29,00 USD el 21-oct [4, 5].

2. Modelo de negocio

Confianza: Alta

Elevance Health es la segunda aseguradora de salud de EE. UU. por afiliados en seguro comercial y la mayor licenciataria de Blue Cross Blue Shield (14 estados): 44,9 M de afiliados médicos a 30-sep-2026 en planes de empresa (asegurados y de autoservicio), individuales del ACA, Medicare Advantage y Medicaid gestionado [4]. Opera en tres negocios: Health Benefits (las primas, ≈ 83 % de los ingresos en 2025), CarelonRx (gestor de farmacia propio desde 2020, farmacia de especialidad e infusión) y Carelon Services (salud conductual, atención domiciliaria, oncología y gestión de especialidades, tras comprar Beacon, CareBridge y Paragon) [1]. Sus clientes son empresas, particulares y, sobre todo, el Estado: Medicaid y Medicare pagan la parte pública de las primas.

Cómo gana dinero

Cobra primas por adelantado y paga la atención médica después: el margen es la diferencia entre la prima y el coste médico (ratio de prestaciones del 87,0 % en 2023, 88,5 % en 2024 y 90,0 % en 2025; 90,6 % en el 3T26) menos los gastos operativos (10,6 % de los ingresos en 2025) [1, 4]. Un punto de ratio de prestaciones sobre ≈ 165.000 M de primas son ≈ 1.650 M de resultado antes de impuestos, unos 5,8 USD por acción (estimación propia). La prima se fija con un año de antelación (comercial) o la fija el Estado (Medicare Advantage, Medicaid), así que un salto del coste médico se come el margen un año y se recupera con retraso. Gana además la renta de la cartera de las filiales reguladas (2.506 M en nueve meses de 2026) y los márgenes de CarelonRx y Carelon Services, sobre todo con los propios afiliados [4]. Estacionalidad: el primer trimestre es el mejor (BPA ajustado de 12,58 USD en el 1T26) y el cuarto el peor (3,33 USD en el 4T25) por los deducibles y la parte D [7, 8].

Segmentos (2025)

Segmento	Ingresos	% del total	Crecimiento	Margen	Tipo de margen
Health Benefits	167.094	84,6 %	+11,2 %	2,5 %	EBIT
CarelonRx	43.400	22,0 %	+20,7 %	5,6 %	EBIT
Carelon Services	28.316	14,3 %	+57,7 %	3,4 %	EBIT
Corporate & Other	463	0,2 %	+49,8 %	-72,8 %	EBIT
Eliminaciones	-41.689	-21,1 %	+42,3 %	0,0 %	EBIT



Ingresos por segmento	2021	2022	2023	2024	2025
Health Benefits	121.728	138.484	148.571	150.275	167.094
CarelonRx	25.431	28.526	33.835	35.961	43.400
Carelon Services	10.130	12.860	14.147	17.961	28.316
Corporate & Other	95	399	479	309	463
Eliminaciones	-20.441	-24.609	-26.823	-29.302	-41.689



Clientes, recurrencia y poder de precios

No hay concentración en un cliente privado, pero sí en el pagador público: Medicaid (contratos estatales que se licitan cada 3-5 años) y Medicare Advantage (tarifas fijadas por CMS cada año) concentran el riesgo [1]. El poder de precios se ve en 2026: la empresa ha subido primas y ha salido de mercados de Medicaid, del ACA y de Medicare Advantage con pérdidas, aceptando perder afiliados: los ingresos operativos crecen un 1,0 % en nueve meses con un 15,5 % menos de afiliados de Medicare Advantage [4]. En Medicaid los estados han ido por detrás del coste; la dirección da 2026 como el suelo del margen y apunta a un 2-4 % [17]. En el comercial, varios grandes empleadores volvieron para 2027 [17].

Indicadores operativos

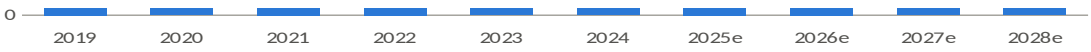
Indicador	Anterior	Actual	Variación	Lectura
Afiliados médicos (millones)	45,4 (3T25)	44,9 (3T26)	−1,1 %	Bajan Medicare Advantage (−15,5 %), Medicaid (−4,9 %) y grupo de riesgo (−6,9 %); suben los de servicios (+1,9 %) [4].
Ratio de prestaciones (sobre primas)	88,9 % (9M25)	89,0 % (9M26)	+10 pb	90,6 % en el 3T26, 70 pb mejor que un año antes; 90,0 % en 2025 frente a 88,5 % en 2024 y 87,0 % en 2023 [4, 8, 12].
Ratio de gastos operativos ajustado	10,4 % (9M25)	10,9 % (9M26)	+50 pb	Inversiones puntuales en tecnología, gestión del coste médico y Carelon, financiadas con la renta no recurrente de la cartera [4, 18].
Días de reservas médicas (DCP)	41,4 (3T25)	44,9 (3T26)	+3,5 días	Más reservas por día de prestaciones: colchón prudente frente a la tendencia de costes [4].
Recetas ajustadas de CarelonRx (M, trimestre)	85,0 (3T25)	82,6 (3T26)	−2,8 %	Menos recetas por la pérdida de afiliados; el margen del segmento sube al 5,3 % [4].
Margen operativo ajustado del grupo	4,8 % (9M25)	4,2 % (9M26)	−60 pb	Health Benefits cae al 2,7 % (3,5 %); Carelon Services al 4,9 %; CarelonRx estable en el 5,3 % [4].

3. Sector y mercado

Confianza: Media

El mercado relevante es el gasto sanitario de EE. UU., donde UnitedHealth cobra primas y servicios: las cuentas nacionales de salud de CMS (National Health Expenditures) lo miden en 5,28 billones de USD en 2024 [24]. Dentro de él, los subsectores de UnitedHealth son el seguro privado (1,64 billones en 2024), Medicare (1,12 billones, del que Medicare Advantage cubre al 55 % de los beneficiarios elegibles en 2026) y Medicaid (0,93 billones), además de los fármacos de receta (467.000 M) que intermedian los gestores de farmacia [24, 27]. Se usa la serie oficial de la Oficina del Actuario de CMS [26]; la segunda fuente, la propia UnitedHealth, sitúa el gasto sanitario en el 19 % del PIB en 2025 [22], frente al 18,0 % de 2024 de CMS [24].

Tamaño del mercado	**5,28 billones de USD en 2024 (18,0 % del PIB) y 5,66 billones estimados en 2025; CMS proyecta 9,0 billones en 2034 [24, 25, 26].**	Posición en el ciclo	**Recuperación**
Crecimiento histórico anual	**6,8 %**	Crecimiento previsto anual	**5,7 %**
Cuota de los 5 primeros	**57 %**	Estructura	**Concentrada**



Motores de la demanda

Motor	Efecto	Horizonte	Evidencia
Envejecimiento y paso a Medicare	+	Estructural	La población de 65 años o más crece un 2,8 % en 2025 y un 2,7 % en 2026; CMS prevé que el gasto de Medicare crezca un 7,7 % anual en 2025-34, frente al 5,0 % del seguro privado [25, 26].
Penetración de Medicare Advantage	+	Estructural	El 55 % de los beneficiarios elegibles (35,2 M) está en Medicare Advantage en 2026, frente al 19 % en 2007; la CBO prevé el 63 % en 2034, aunque el crecimiento se frena (+3 % en 2026) [27].
Utilización y coste médico	–	Cíclico	En 2025 subió el ratio de siniestralidad de todo el sector: UnitedHealth del 85,5 % al 89,1 %, Elevance del 88,5 % al 90,0 %, Centene del 88,3 % al 91,9 % y Molina del 89,1 % al 91,7 % [1, 22, 31, 32]. CMS prevé que el gasto se modere del 7,3 % en 2025 al 6,3 % en 2026 por menor utilización [25].
Tarifas de Medicare Advantage y ajuste por riesgo	+/–	Cíclico	Subida de pagos del 5,06 % en 2026 y del 2,48 % en 2027 (4,98 % con la tendencia de puntuaciones de riesgo); la revisión del modelo de riesgo resta un 1,12 % en 2027 y la exclusión de diagnósticos de revisiones de historias no vinculadas, un 1,53 % [33, 35].
Recortes de Medicaid y fin de los subsidios reforzados del ACA	–	Estructural	CMS prevé 3,7 M menos de asegurados en compra directa en 2026 por el fin de los subsidios reforzados y 2,6 M menos en Medicaid en 2027-28 por los requisitos de la ley OBBBA; el seguro de la población baja del 91,8 % en 2024 al 90,4 % en 2028 [25].
Fármacos de especialidad y GLP-1	+/–	Estructural	El gasto en fármacos de receta crece un 11,1 % en 2025 (518.700 M) por diabetes y obesidad [25]; más volumen para los gestores de farmacia y más coste para las aseguradoras. Optum Rx gestionó 87.000 M en especialidad en 2025 [22].

Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada

Poder de los proveedores

Fuerza	Intensidad (1-5)	Justificación
Rivalidad	4	Los afiliados cambian de aseguradora cada año: en Medicare Advantage Humana ganó 1,3 M de afiliados en 2026 y UnitedHealth perdió 647.000 [27]. Los márgenes operativos de 2025 fueron bajos: del −3,9 % de Centene al 4,2 % de UnitedHealth [1, 22, 28, 29, 30, 31, 32].
Poder de los clientes	4	El Estado fija el precio en Medicare y Medicaid: CMS propuso una subida de solo el 0,09 % para 2027 y es el 44 % de los ingresos de UnitedHealth [22, 34]. Las grandes empresas se autoaseguran: 21,5 M de los 29,7 M de afiliados comerciales de UnitedHealth están en contratos de solo administración [22].
Poder de los proveedores	4	El gasto hospitalario creció un 8,9 % en 2024 [24]. UnitedHealth atribuye el coste comercial elevado a precios de los proveedores, servicios agrupados por visita y al arbitraje de la ley No Surprises [23]. Los laboratorios fijan el precio de los fármacos de especialidad.
Amenaza de entrada	2	Hacen falta capital regulado, redes de proveedores y escala: los cinco mayores tienen el 57 % del seguro comercial y en el 97 % de las áreas metropolitanas el mercado está muy concentrado [37]. Hay entrantes en Medicare Advantage: Devoted Health ganó 258.000 afiliados en 2026 [27].
Amenaza de sustitutos	2	El sustituto de Medicare Advantage es Medicare tradicional (el 45 % de los elegibles sigue en él) [27]; el del seguro con riesgo, el autoaseguramiento de la empresa, que UnitedHealth también administra [22].

Ciclo

El sector viene de un ciclo de siniestralidad alta: en 2025 el ratio subió entre 1,5 y 3,6 puntos en las grandes aseguradoras y Centene registró un deterioro de 6.700 M [1, 22, 31, 32]. En 2026 las primas se han subido y se han recortado prestaciones y afiliados: el MCR de UnitedHealth bajó al 86,7 % en el 2T26 [23, 39] y el ratio de prestaciones de Elevance mejoró 70 pb en el 3T26 (90,6 %), con Medicaid ayudado por las tarifas del 1-jul y la tendencia de coste «elevada pero estable» [4, 17]. En 2020 la utilización se hundió (el gasto del seguro privado creció solo un 0,4 %) y repuntó en 2023 (+11,2 %) [26]. La serie de CMS no cubre 2008-09.

Regulación

Medicare Advantage: CMS subió los pagos un 5,06 % para 2026 (más de 25.000 M) y, tras proponer un 0,09 % el 26-ene-2026, fijó un 2,48 % para 2027 el 6-abr-2026 (más de 13.000 M; 4,98 % con la tendencia de riesgo); renunció al nuevo modelo de riesgo de 2027 y mantiene el de 2024 (V28), pero excluye diagnósticos de revisiones de historias no vinculadas [33, 34, 35]. Farmacia: la ley de presupuestos firmada a principios de febrero de 2026 desvincula la remuneración de los gestores de farmacia del precio de los fármacos en Part D y obliga a trasladar los descuentos [38]. ACA: expiraron los subsidios reforzados (−3,7 M asegurados en 2026) [25]. Medicaid: la ley OBBBA limita impuestos a proveedores y pagos dirigidos y exige requisitos de trabajo [25]. Elevance cita además los arbitrajes de la ley No Surprises (IDR), que le han obligado a reconocer 669 M de pasivos, sobre todo de clientes autoasegurados [5, 17].

Tendencias y disrupción

Tres tendencias pesan en las cifras. Primera, la integración vertical: aseguradora, gestor de farmacia y médicos propios en un mismo grupo (UnitedHealth con Optum, CVS con Aetna y Caremark, Cigna con Express Scripts); es la base del modelo de UnitedHealth, pero atrae la regulación de los gestores de farmacia [38]. Segunda, el paso de pago por acto a atención basada en valor, que en 2025 dio pérdidas a Optum Health (−278 M) por la reducción de las tarifas de Medicare [22]. Tercera, la caída de la cuota de los grandes en Medicare Advantage frente a Humana, Kaiser y aseguradoras nuevas (Devoted, SCAN) [27]. La inteligencia artificial y la regulación de datos aparecen como riesgo y oportunidad en el 10-K [22].

4. Posición competitiva y foso

Confianza: Media

Cuota de mercado	**12,0 %**	Posición	**2.° en seguro médico comercial en EE. UU. (12 % de los afiliados en 2024, detrás de UnitedHealth con el 16 %) [37]; ≈ 5 % de Medicare Advantage [27] (1,9 M de afiliados a 30-sep-2026, −15,5 % en un año); 8,2 M de afiliados de Medicaid y 1,3 M en el ACA [4]. Sus ingresos de 2025 equivalen al 3,5 % del gasto sanitario nacional estimado (estimación propia: 197.584 M sobre 5,66 billones) [1, 26].**
Foso	**Estrecho**	Tendencia del foso	**Estable**

Competidor	País	Cotiza	Ingresos (M)	Cuota	M. EBIT	Cómo compite
UnitedHealth Group	EE. UU.	UNH	447.567	16,0 %	4,2 %	1.° en seguro comercial (16 %) y en Medicare Advantage (26 %), con Optum (servicios, tecnología y farmacia). Ratio de siniestralidad del 89,1 % en 2025 [22, 27, 37].
CVS Health (Aetna, CVS Caremark)	EE. UU.	CVS	402.067	12,0 %	1,2 %	Modelo integrado como UnitedHealth: aseguradora (26,6 M de afiliados médicos, MBR del 91,2 %), Caremark (1.900,7 M de recetas) y farmacias. Beneficio operativo de 4.660 M en 2025. Cuota en Medicare Advantage [27, 29].
The Cigna Group (Express Scripts, Evernorth)	EE. UU.	CI	274.900	–	3,3 %	Líder en gestión de farmacia: Express Scripts procesó 2.220 M de recetas en 2025 (≈31 % del mercado, estimación propia) [36]. Vendió Medicare Advantage a HCSC; 18,1 M de clientes médicos y MCR del 84,4 % en Cigna Healthcare [28].
Centene	EE. UU.	CNC	194.777	–	-3,9 %	Líder en Medicaid gestionado y en el seguro individual del ACA; 27,6 M de afiliados y HBR del 91,9 %. Pérdida operativa de 7.623 M en 2025 por un deterioro de fondo de comercio de 6.700 M [31].
Humana	EE. UU.	HUM	129.664	20,0 %	2,1 %	2.° en Medicare Advantage y el que más crece (+1,3 M de afiliados en 2026) [27]. Ratio de prestaciones del 90,2 % y 15,0 M de afiliados médicos en 2025; CenterWell (atención primaria y domiciliaria) compite con Optum Health [30].
Molina Healthcare	EE. UU.	MOH	45.426	–	1,7 %	Medicaid, Medicare y ACA; 5,5 M de afiliados y MCR del 91,7 % en 2025 (89,1 % en 2024); compite con Community & State en concursos estatales [32].

Fuentes de ventaja competitiva



Fuente	Puntuación (0-5)	Evidencia
Efectos de red	2	La red de proveedores de Blue Cross Blue Shield (descuentos negociados en 14 estados) atrae a empresas, pero el afiliado no gana valor con más afiliados [7].
Costes de cambio	2	Los contratos de seguro se renuevan cada año; el grupo de empresa (ASO) es más estable que Medicare Advantage o Medicaid, que se licitan o se eligen cada año [7].
Intangibles (marca, patentes, licencias)	4	Licencia exclusiva de la marca Blue Cross Blue Shield en 14 estados: es la principal barrera y explica el 12 % de cuota en seguro comercial [7, 17].
Ventaja en costes	3	Ratio de gastos operativos del 10,6 % en 2025, el más bajo entre las grandes (UnitedHealth 13,3 %, Humana 12,0 %) [1, 7, 10].
Escala eficiente	3	44,9 M de afiliados médicos a 30-sep-2026: escala local para negociar con hospitales, pero menor que UnitedHealth (49,8 M en 2025) y sin una Optum [7, 28].

Amenazas

La regulación es la amenaza principal: Medicaid (requisitos de trabajo y límites de financiación de la ley H.R. 1 desde 2027), ajuste de riesgo de Medicare Advantage (V28 y fuentes de diagnóstico, y el caso de CMS de 2026) y el fin de los subsidios reforzados del ACA reducen afiliados e ingresos por miembro justo en los negocios públicos donde Elevance perdió margen en 2025 [5, 33, 34]. En comercial, la presión viene de los hospitales (consolidación), de los arbitrajes IDR y de los fármacos GLP-1 y de especialidad [17]. Es una erosión de margen, no de la franquicia Blue: en la campaña de 2027 «varios grandes empleadores» volvieron a Anthem tras un año fuera [17].

Parte II — Finanzas

5. Cuenta de resultados

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec.	M. bruto	EBITDA	M. EBITDA	EBIT	M. EBIT	B. neto	BPA	DPA	Tipo imp.
2021	136.943	–	17,1 %	10.027	7,3 %	8.725	6,4 %	6.158	24,95	4,52	23 %
2022	155.660	+13,7 %	16,7 %	10.683	6,9 %	9.008	5,8 %	5.894	24,28	5,12	23 %
2023	170.209	+9,3 %	16,8 %	11.901	7,0 %	10.156	6,0 %	5.987	25,22	5,92	22 %
2024	175.204	+2,9 %	15,9 %	11.967	6,8 %	10.574	6,0 %	5.980	25,68	6,52	25 %
2025	197.584	+12,8 %	14,3 %	10.338	5,2 %	8.792	4,4 %	5.662	25,21	6,84	16 %

Crecimiento anual compuesto 2021-2025: ingresos **9,6 %**, EBITDA **0,8 %**, BPA **0,3 %**.



Los ingresos operativos pasaron de 136.943 M en 2021 a 197.584 M en 2025 (+12,8 % solo en 2025, con primas más altas, más afiliados de Medicaid de alta complejidad y las compras de CareBridge, Centers y Paragon) [1, 2]. El beneficio no acompañó: el EBIT (con la renta de la cartera y después de amortizar intangibles) bajó de 9.439 M en 2023 a 8.765 M en 2025, porque el ratio de prestaciones subió del 87,0 % (2023) al 88,5 % (2024) y al 90,0 % (2025), con Medicaid, el ACA y la parte D por delante de las tarifas [8, 12, 13]. En los últimos doce meses a septiembre de 2026 los ingresos apenas crecen (199.071 M) porque la empresa salió de mercados de Medicare Advantage y Medicaid; el margen operativo ajustado de los nueve meses baja al 4,2 % (4,8 %) por inversiones puntuales, mientras el ratio de prestaciones del 3T26 mejora 70 pb [4]. El BPA aguantó gracias a la recompra (de 246,8 a 224,6 M de acciones entre 2021 y 2025) y a un tipo del 15,6 % en 2025 [1].

Ajustes y partidas no recurrentes

Cuentas en US GAAP; 2021 y 2022 reexpresados por la norma de contratos de larga duración (LDTI, ASU 2018-12) en el 10-K 2023 [2]. Elevance publica un BPA ajustado que excluye la amortización de intangibles comprados, los resultados de instrumentos financieros, los costes de operaciones e integración, las reorganizaciones, los litigios y, en 2026, la provisión de 935 M por el aviso de CMS sobre datos de riesgo de Medicare Advantage: 30,29 USD en 2025 frente a 25,21 contables, y una guía de 2026 de al menos 29,00 frente a 22,00 contables [4, 8]. Como partidas no recurrentes dentro del EBITDA van las reorganizaciones, los litigios, las ventas de negocios y la provisión de CMS (1.241 M en 2024, 717 M en 2023, 1.120 M en los últimos doce meses); los costes de integración (≈ 130-240 M al año) se repiten y se dejan como gasto [1, 4, 8, 12, 13, 14, 15]. Además, la renta de inversiones de 2026 lleva ajustes de valoración no recurrentes: 0,80 USD por acción en el 2T26 y la mayor parte de los 1,85 USD de beneficio no operativo neto del 3T26 [17, 18].

6. Resultados recientes

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec. interanual	EBITDA	M. EBITDA	BPA	Frente al consenso
4T24	44.989	+6,0 %	1.418	3,2 %	1,81	En línea
1T25	48.765	+15,4 %	3.978	8,2 %	9,61	Superior
2T25	49.421	+14,3 %	3.144	6,4 %	7,72	Inferior
3T25	50.087	+12,0 %	2.145	4,3 %	5,32	Superior
4T25	49.311	+9,6 %	1.044	2,1 %	2,47	Superior
1T26	49.494	+1,5 %	3.093	6,2 %	8,00	Superior
2T26	49.826	+0,8 %	2.723	5,5 %	6,71	Superior
3T26	50.440	+0,7 %	2.563	5,1 %	6,27	Superior



Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

En el 3T26 (21-oct-2026) la dirección subió la guía de BPA ajustado a «al menos» 29,00 USD y, sobre todo, la base de partida de 2026 para el crecimiento de 2027 a 26,75 USD (26,00 tras el 2T26), y repitió el +12 % de BPA ajustado para 2027 [4, 17]. El 3T26 tuvo ≈ 0,50 USD de mejora operativa (Medicaid por las tarifas del 1-jul, Medicare Advantage por la cartera retenida y el ACA por menor coste de los planes bronce) y 1,85 USD de beneficio no operativo neto, sobre todo ajustes de valoración en la renta de inversiones [17]. Entre una conferencia y otra cambia el tono sobre Medicaid: en julio el margen «se mantenía prudente» y la empresa anunciaba salidas de mercados (Distrito de Columbia) en 12-18 meses; en octubre va «ligeramente por delante» y 2026 es «el suelo», con objetivo del 2-4 % a largo plazo [17, 18]. Medicare Advantage cerrará 2026 con un margen de al menos el 2 % (objetivo 3-5 %) [17]. Los analistas preguntaron sobre todo por Medicaid (requisitos de trabajo de la ley H.R. 1, acuidad, tarifas de 2027), por los arbitrajes de la ley No Surprises (IDR) y por el ACA tras el fin de los subsidios reforzados. La dirección no cuantificó el puente al +12 % de 2027 ni la recompra que incluye («más detalle en enero») [17].

7. Balance y capital circulante

Periodo	Activo total	Fondo com. + intang.	Circulante	Caja	Deuda fin.	Arrend.	Deuda neta	Patrimonio	DN/ EBITDA
2021	97.460	34.843	8.470	4.880	23.031	0	18.151	36.060	1,8x
2022	102.755	34.698	10.437	7.387	24.114	0	16.727	36.243	1,6x
2023	108.928	35.590	10.955	6.526	25.120	0	18.594	39.306	1,6x
2024	116.889	40.371	12.144	8.288	31.232	0	22.944	41.315	1,9x
2025	121.494	39.544	14.220	9.491	32.046	0	22.555	43.882	2,2x

Periodo	Circulante / ventas	Días de cobro	Días de pago	Liquidez corriente
2021	6,2 %	36	16	1,5x
2022	6,7 %	38	16	1,4x
2023	6,4 %	38	18	1,4x
2024	6,9 %	40	17	1,4x
2025	7,2 %	40	16	1,5x

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

Cambio de perímetro (2024: CareBridge (10-dic-2024) y Centers (31-dic-2024), consolidadas al cierre: entran en el balance de 2024 y en la cuenta desde 2025; Paragon desde marzo de 2024. Pagos por compras de 4.809 M en 2024 [1].). Los ratios de balance de ese año (días, circulante, deuda neta / EBITDA, ROIC) y los indicadores de calidad contable no son comparables con los anteriores.

La deuda financiera bruta pasó de 23.031 M (2021) a 32.046 M (2025) para pagar compras (4.809 M en 2024) y recompras; a 30-sep-2026 baja a 30.757 M tras amortizar 750 M en marzo [1, 4, 5]. La caja consolidada (10.348 M) y la cartera de inversiones respaldan las reservas médicas y el capital exigido a las filiales; la que puede usar el accionista es la de la matriz (2.416 M) [5]. Las cuentas a cobrar suben de 21.542 M a 24.573 M en nueve meses y otros pasivos corrientes de 22.702 M a 27.849 M, por el calendario de cobros y pagos con CMS y los estados; por eso el flujo operativo de los nueve meses (7.512 M) casi duplica el de 2025 (4.206 M) [4].

8. Flujos de caja

Confianza: Alta

Periodo	Flujo operativo	Capex	Arrend.	FCF	B. neto	FCF / B. neto	Capex / ventas	Capex / amort.	FCF por acción
2021	8.364	1.087	0	7.277	6.158	118 %	0,8 %	0,8x	29,49
2022	8.399	1.152	0	7.247	5.894	123 %	0,7 %	0,7x	29,85
2023	8.061	1.296	0	6.765	5.987	113 %	0,8 %	0,7x	28,50
2024	5.808	1.256	0	4.552	5.980	76 %	0,7 %	0,9x	19,54
2025	4.290	1.116	0	3.174	5.662	56 %	0,6 %	0,7x	14,13



Acumulado 2021-2025: FCF **29.015**, conversión **98 %** del beneficio neto; adquisiciones 10.486, dividendos 6.765, recompras 12.397.

La conversión del beneficio en caja se ha deteriorado: el flujo operativo cayó de 8.364 M (2021) a 4.290 M (2025), por debajo del beneficio neto (5.662 M), por el aumento de las cuentas a cobrar (−2.526 M en 2025) y el pago de reservas [1]. En 2026 rebota: 7.512 M en nueve meses y una guía de al menos 6.500 M para el año, con efecto favorable del circulante que se dará la vuelta en parte [4, 17]. El capex es pequeño (1.087-1.296 M, 0,6-0,8 % de los ingresos) y es casi todo tecnología de mantenimiento y desarrollo; la inversión que de verdad exige crecer es el capital regulatorio que retienen las filiales (estimación propia en el DCF). De 2021 a 2025 se dedicaron 12.397 M a recompras, 6.765 M a dividendos y 10.486 M a compras [1, 2].

9. Calidad contable

Confianza: Alta

Auditor	**Ernst & Young LLP**	Años como auditor	**82**
Opinión del último informe	**Favorable**	Ejercicio analizado	**2025**

Indicador	Valor	Lectura
Altman Z	3,23	Zona segura (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo.
Piotroski F	6 / 9	Intermedio (4-6).
Beneish M	-2,25	Por debajo de −1,78: sin señal de manipulación.
Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)	1,18x	El beneficio se cobra.

Criterio Piotroski	Cumple
Beneficio neto positivo	Sí
Flujo operativo positivo	Sí
ROA mejora	No
Flujo operativo > beneficio neto	No
Baja el endeudamiento (deuda / activo)	Sí
Mejora la liquidez corriente	Sí
No emite acciones	Sí
Mejora el margen bruto	No
Mejora la rotación del activo	Sí

Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

Ernst & Young audita a la empresa desde 1944 y señala como asunto clave de auditoría la estimación de las prestaciones ocurridas y no comunicadas [1]. La principal fuente de juicio es la reserva médica: en 2025 la empresa liberó 1.290 M de reservas de años anteriores (1,0 % de las prestaciones del año anterior), menos que los 1.731 M de 2024 (1,4 %), y a septiembre de 2026 los días de reservas suben a 44,9 [4]. El BPA ajustado excluye partidas que se repiten cada año (costes de integración, reorganizaciones) y en 2026 una provisión de 935 M por datos de riesgo de Medicare Advantage, que es un coste del negocio ya pagado en parte [4, 5]. La renta de inversiones de 2026 incluye ajustes de valoración no recurrentes que la empresa sí cuenta en el BPA ajustado (≈ 2,65 USD por acción entre 2T y 3T) pero excluye de la base de 2026 (26,75) [17, 18]. Pagos en acciones moderados (276 M en 2025, 4,9 % del beneficio) [1].

Señales de alerta

Señal	Nivel	Explicación
Renta de inversiones no recurrente dentro del BPA ajustado	Media	Ajustes de valoración de 0,80 USD (2T26) y la mayor parte de 1,85 USD (3T26) por acción: la guía de 29,00 incluye ≈ 2,25 USD que la propia empresa excluye de la base de 26,75 [4, 17, 18].
Provisión por el aviso de CMS sobre datos de riesgo de Medicare Advantage	Media	935 M dotados en el 1T26, excluidos del BPA ajustado; rango ±320 M [5]. El mismo asunto sostiene la demanda del Departamento de Justicia.
Conversión de caja baja en 2024-2025	Media	Flujo operativo de 4.290 M frente a un beneficio de 5.662 M en 2025, por cobros pendientes de gobiernos [1].
Menos liberación de reservas de años anteriores	Baja	1,0 % de las prestaciones del año anterior en 2025 frente al 1,4 % de 2023-2024: reservas menos holgadas o costes más altos [4].

10. Rentabilidad sobre el capital

Confianza: Media

Periodo	ROIC	ROE	ROA	Margen neto	Rotación del activo	Apalancamiento	Capital invertido	ROIC sin f. de comercio
2021	12,4 %	17,1 %	6,3 %	4,5 %	1,41x	2,70x	54.279	22,3 %
2022	13,0 %	16,3 %	5,9 %	3,8 %	1,55x	2,77x	53.668	23,8 %
2023	14,2 %	15,8 %	5,7 %	3,5 %	1,61x	2,80x	55.528	25,7 %
2024	13,1 %	14,8 %	5,3 %	3,4 %	1,55x	2,80x	61.185	23,2 %
2025	11,3 %	13,3 %	4,8 %	2,9 %	1,66x	2,80x	65.476	20,0 %

Fondo de comercio y compras

Fondo de comercio: 28.344 M en 2025 (el 43 % del capital invertido medio); ha subido más de un 5 % en 1 de 4 años: compras pequeñas. ROIC publicado 11,3 %; sin fondo de comercio, 20,0 %. El ROIC sin fondo de comercio mide el rendimiento del negocio operativo; decide el publicado (§4.1) y la cifra sin fondo de comercio es dato para una excepción razonada.

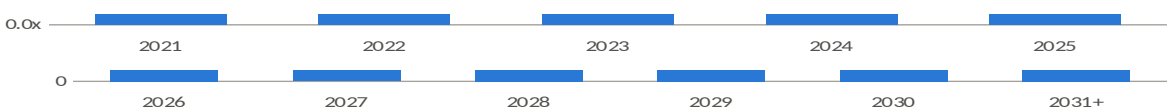
ROIC incremental (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): 6,3 % · **WACC**: 8,5 %.

Elevance crea valor, pero con poco margen: el ROIC fue del 12,4-14,2 % en 2021-2024 y bajó al 11,3 % en 2025, 2,8 puntos por encima del WACC (8,54 %) y por debajo de los 5 puntos que pedimos para comprar. Sin el fondo de comercio el ROIC sería del 20,0 %: el 44-45 % del capital invertido son compras pasadas (WellPoint, Amerigroup, MMM, BioPlus, Paragon, CareBridge) [1]. La caída de 2025 es de margen, no de rotación: el margen neto pasó del 4,5 % (2021) al 2,9 % (2025) mientras la rotación del capital se mantenía en 1,4-1,6 veces. El ROIC incremental de 2021-2025 es solo del 6,3 %, por debajo del WACC: las compras de 2024 (4.809 M) y el capital puesto en Carelon aún no rinden lo que el negocio original [1, 4]. El NOPAT incluye la renta de las inversiones reguladas; con la cartera dentro del capital invertido el ROIC sería más bajo. La recuperación de 2027 (BPA ajustado ≥ 29,96 USD) llevaría el ROIC hacia el 13 % (estimación propia); frente a los comparables (mediana 9,4 %), sigue en la mitad alta.

11. Deuda y solvencia

Confianza: Alta

Deuda neta a 30 sep 2026	**28.341 M**	Deuda neta / EBITDA últimos 12 m	**2,7x**
Pasivos asimilables a deuda (pensiones y otros)	**593 M**	Deuda neta ajustada	**28.934 M**
Deuda neta ajustada / EBITDA	**2,7x**	Liquidez disponible	**Caja e inversiones de la matriz de 2.416 M a 30-sep-2026; línea de crédito a 5 años de 5.000 M (vence en septiembre de 2030) sin disponer y programa de pagarés de 5.000 M sin saldo [5].**
		Coste medio de la deuda	**4,6 %**



Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

Reservas médicas de 18.438 M (44,9 días de prestaciones) a 30-sep-2026 [4]. Provisión por el aviso de CMS de febrero de 2026 sobre datos de riesgo de Medicare Advantage de 2015-2023: 935 M dotados, 342 M pagados el 27-may-2026 y 593 M pendientes; el rango posible va de 320 M menos a 320 M más [5]. Demanda del Departamento de Justicia por la Ley de Reclamaciones Falsas (datos de riesgo de la parte C): pruebas periciales hasta el 2-ago-2027 [5]. Arbitrajes IDR: pasivos de 669 M, de los que 625 M son de clientes autoasegurados y se recuperan (cuentas a cobrar de 575 M) [5]. Demanda colectiva de valores por la guía de 2024 (el juez denegó en septiembre de 2026 la desestimación) y tres demandas derivadas [5]. Ratio deuda/capital del 40,7 % según el contrato de la línea de crédito, con holgura sobre el covenant [5].

12. Asignación de capital

Confianza: Media

Dividendo trimestral de 1,72 USD (6,88 al año, ≈ 1,6 % al precio actual), pagado desde 2011 y subido cada año [4]. Autorización de recompra pendiente de 5.007 M a 30-sep-2026; en nueve meses se recompraron 5,2 M de acciones por 1.688 M (324,88 USD de media) [5]. Para 2027 la dirección promete disciplina: mantener la solidez del balance, financiar inversiones y ser «oportunista» en recompras; a largo plazo, reinversión, compras selectivas y devolución de capital [17].

Periodo	FCF	Adquisiciones	Dividendos	Recompras	Ampliaciones	Retorno / B. neto	Acciones (M)
2021	7.277	3.476	1.104	1.900	203	49 %	246,8
2022	7.247	649	1.229	2.316	182	60 %	242,8
2023	6.765	1.552	1.395	2.676	152	68 %	237,4
2024	4.552	4.809	1.508	2.900	221	74 %	232,9
2025	3.174	0	1.529	2.605	79	73 %	224,6



Historial de adquisiciones

Año	Objetivo	Importe	Financiación	Resultado
2021	MMM Holdings (Medicare Advantage en Puerto Rico), myNEXUS y otras (total del año)	3.476	Caja y deuda	Sin deterioros del fondo de comercio publicados [2].
2022	Integra Managed Care (Medicaid de cuidados de larga duración en Nueva York)	649	Caja	Sin deterioros publicados [2].
2023	BioPlus (farmacia de especialidad, CarelonRx)	1.552	Caja	Base de la farmacia de especialidad; la dirección cita su centro de oncología de 2026 [2, 17].
2024	Paragon Healthcare (infusión), CareBridge (atención domiciliaria) y Centers (Medicaid de larga duración en Nueva York) (total del año)	4.809	Deuda (7.710 M emitidos en 2024)	Explican el salto de ingresos de Carelon Services en 2025 (+57,7 %) con margen bajo (3,4 %) [1].

La asignación de capital es razonable pero no excelente. A favor: dividendo creciente desde 2011 (1,72 USD por trimestre), recompras constantes (2.605 M en 2025 y 1.688 M en nueve meses de 2026, a 324,88 USD de media, muy por debajo del precio actual) y deuda estable en ≈ 31.000 M [1, 5]. En contra: 10.486 M de compras en 2021-2024

cuyo rendimiento no se ve todavía (ROIC incremental del 6,3 %) y un flujo operativo que cayó a 4.290 M en 2025, por debajo del beneficio, por el capital circulante con CMS y los estados [1]. En 2026 el flujo vuelve (7.512 M en nueve meses, guía ≥ 6.500 M) y la dirección promete para 2027 «disciplina» y recompras «oportunistas», sin cifra [4, 17]. La caja de la matriz (2.416 M) es la que limita las recompras: depende de los dividendos que las filiales reguladas puedan pagar.

Parte III — Equipo y gobierno

13. Equipo directivo

Confianza: Alta

Nombre	Cargo	Desde	% capital	Trayectoria y resultados
Gail K. Boudreaux	Presidenta y consejera delegada	2017	0,20 %	Antes dirigió UnitedHealthcare (2008-2014). Con ella el BPA ajustado pasó de 19,44 USD (2019) a 33,14 (2023) y la empresa creó Carelon (farmacia y servicios); en 2024 y 2025 incumplió la guía de enero (37,10 y 34,50 USD frente a 33,04 y 30,29) [12, 13, 14]. Compró 2.725 acciones (1,0 M USD) en julio de 2026 [44]. Participación: 442.597 acciones con opciones ejercitables (0,2 %) [40].
Mark Kaye	Vicepresidente ejecutivo y director financiero	2023	0,01 %	Antes director financiero de Moody's (2018-2023) y responsable de planificación en MassMutual [1]. Vendió 10.584 acciones por 4,66 M USD el 22-oct-2026, al día siguiente de los resultados, sin plan 10b5-1 [44]. Remuneración de 7,99 M USD en 2025 [40].
Felicia F. Norwood	Vicepresidenta ejecutiva, responsable de Health Benefits (antes de los negocios públicos)	2018	0,04 %	Antes directora del departamento de sanidad de Illinois (2015-2018) y directiva de Aetna [1]. Dirige el negocio de seguros (Medicare, Medicaid y comercial) y explica la recuperación de Medicare Advantage hacia el margen del 2 % en 2026 [17]. 97.429 acciones con opciones [40].
Morgan Kendrick	Vicepresidente ejecutivo, presidente de Commercial Health Benefits	2021	0,02 %	En la empresa desde 1995; presidente del negocio comercial desde octubre de 2021 [1]: en la campaña de 2027 recuperó grandes empleadores que se habían ido un año antes [17]. Vendió 3.196 acciones (0,91 M USD) en marzo de 2026 [44].
Jeff Park	Presidente de Carelon	2026	–	Sustituye a Peter Haytaian, que dejó Carelon el 4-may-2026 por motivos familiares y sigue de asesor hasta fin de año [17, 45]. Experiencia previa en servicios sanitarios y farmacia, según la dirección [17].
Ramiro G. Peru	Presidente independiente del consejo	2004	0,00 %	Consejero desde 2004 y presidente independiente desde 2025, tras la jubilación de Elizabeth Tallett [40]. Compró 1.000 acciones (0,37 M USD) en julio de 2026 [44].

¿Cumple lo que promete?

Año	Lo que prometió	Lo que logró	Cumplió
2021	BPA ajustado > 24,50 USD (enero)	25,98 USD	Sí
2022	BPA ajustado > 28,25 USD (enero)	29,07 USD	Sí
2023	BPA ajustado > 32,60 USD (enero)	33,14 USD	Sí
2024	BPA ajustado > 37,10 USD (enero)	33,04 USD	No
2025	BPA ajustado de 34,15-34,85 USD (enero)	30,29 USD	No
2026	BPA ajustado ≥ 25,50 USD (enero); ≥ 26,75 (abril), ≥ 27,00 (julio) y ≥ 29,00 (octubre)	27,06 USD en nueve meses	Sí

Equipo estable y con experiencia: Boudreaux lleva desde 2017 y antes dirigió UnitedHealthcare; Norwood (negocios de seguro) y Kendrick (comercial) llevan años en sus puestos [1, 40]. La credibilidad sufrió con dos guías incumplidas (2024 y 2025), pero 2026 la recupera: la guía de BPA ajustado se ha subido tres veces, de ≥ 25,50 a ≥ 29,00 USD [4, 8]. La señal de los directivos es mixta: la consejera delegada y el presidente compraron en julio, a ≈ 370 USD, y el director financiero vendió 4,66 M USD el 22-oct, sin plan 10b5-1, el día siguiente a subir la guía [44]. Carelon cambió de presidente en mayo; el sucesor (Jeff Park) es nuevo [17, 45].

14. Gobierno corporativo

Confianza: Alta

Consejeros	**12**	Independientes	**92 %**
Antigüedad media en el consejo	**8,5 años**	Criterios de buen gobierno cumplidos	**10 de 13**
Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses)	**0**		

Consejero	Cargo	Tipo	Desde	Comisiones
Ramiro G. Peru	Presidente	Independiente	2004	Remuneración y talento; Gobierno
Gail K. Boudreaux	Consejera delegada	Ejecutivo	2017	–
R. Kerry Clark	Consejero (se jubiló en la junta de 2026)	Independiente	–	Auditoría; Finanzas
Steven H. Collis	Consejero	Independiente	2025	Auditoría; Finanzas
Susan D. DeVore	Consejera	Independiente	2021	Finanzas (presidenta); Remuneración y talento
Robert L. Dixon, Jr.	Consejero	Independiente	2011	Remuneración y talento; Finanzas
Lewis Hay, III	Consejero	Independiente	2013	Auditoría; Finanzas
Bahija Jallal	Consejera	Independiente	2018	Gobierno (presidenta); Remuneración y talento
Antonio F. Neri	Consejero	Independiente	2017	Remuneración y talento (presidente); Gobierno
Ryan M. Schneider	Consejero	Independiente	2019	Auditoría (presidente); Gobierno
Amy W. Schulman	Consejera	Independiente	2026	Auditoría; Finanzas
Deanna D. Strable	Consejera	Independiente	2022	Auditoría; Gobierno

Criterio	Dato	Resultado
Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)	92 %	Cumple
Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control	Sin control	Cumple
Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente	No ejecutivo	Cumple
Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno	Sí	Cumple
Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años	Ninguno	Cumple
Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses	0 cambios	Cumple
Peor voto en contra sobre remuneración (3 juntas) ≤ 20 %	8,2 % en contra	Cumple
Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)	No	No cumple
Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios	Sí	Cumple
Sin operaciones vinculadas relevantes	No hay	Cumple
Auditor con 10 años o menos en el cargo	82 años	No cumple
Opinión de auditoría sin salvedades	Favorable	Cumple
Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)	Compras 2,24 / ventas 6,41 M	No cumple

Accionariado

Accionista	% capital	Tipo	Movimientos recientes
The Vanguard Group	10,10 %	Gestora (13G/A)	22,9 M de acciones a 31-dic-2025
BlackRock	7,80 %	Gestora (13G/A)	17,7 M de acciones a 31-dic-2025
Consejeros y directivos (19 personas)	0,30 %	Directivos	799.910 acciones con opciones ejercitables a 1-feb-2026



Compras y ventas de consejeros y directivos (12 meses)

Fecha	Persona	Operación	Acciones	Importe (M)
22 oct 2026	Kaye Mark (EVP & CFO)	Venta	10.584	4,66
17 jul 2026	PERU RAMIRO G (Consejero)	Compra	1.000	0,37
17 jul 2026	BOUDREAUX GAIL (President and CEO)	Compra	2.725	1,00
12 jun 2026	Penczek Ronald W (CAO & Controller)	Venta	369	0,15
11 jun 2026	Dixon Robert L JR (Consejero)	Venta	151	0,06
19 may 2026	Penczek Ronald W (CAO & Controller)	Venta	1.531	0,62
12 mar 2026	SCHULMAN AMY W (Consejero)	Venta	26	0,01
6 mar 2026	Kendrick Charles Morgan JR (EVP & President, Commercial)	Venta	3.196	0,91
5 mar 2026	COLLIS STEVEN H (Consejero)	Compra	3.000	0,87

Remuneración

Remuneración total del primer ejecutivo (2025)	**22,58 M**	Fijo	**1,60 M**
Variable anual	**2,77 M**	Variable a largo plazo	**17,64 M**
Peor voto a favor (3 juntas)	**91,6 %**	Peor voto en contra (3 juntas)	**8,2 %**
Ratio sobre salario medio	**286x**		

La consejera delegada cobró 22,58 M USD en 2025: 1,60 M de fijo, 2,77 M de variable anual (el 86,5 % del objetivo) y 17,64 M en acciones y opciones; la relación con el empleado mediano es de 286 a 1 [40]. El variable anual pesa un 50 % el beneficio neto ajustado, un 20 % los ingresos operativos y un 30 % iniciativas estratégicas; las acciones por objetivos (PSU) miden el BPA ajustado y los ingresos [40]. Ninguna métrica es de rentabilidad sobre el capital ni de caja, y las dos financieras pueden premiar crecer comprando y recomprando. Hay cláusula de recuperación (también por daño reputacional), prohibición de coberturas y pignoración, y voto consultivo anual: 95,9 % a favor en 2026, 91,7 % en 2025 y 91,6 % en 2024 [40, 41, 42, 43].

Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

No hay accionista de control: los dos mayores son gestoras indexadas (Vanguard 10,1 %, BlackRock 7,8 %) [40]. Una sola clase de acciones. La defensa principal es el consejo escalonado (cada consejero se elige para tres años): la empresa dice que lo desclasificará si la asociación Blue Cross Blue Shield deja de exigirlo a sus licenciatarias [40, 41]. La licencia Blue limita además quién puede comprar la empresa. El presidente del consejo es independiente desde 2025 y todas las comisiones son de independientes [40].

Señales de alerta

- Aviso de sanciones de CMS en Medicare Advantage (27-feb-2026) por datos de riesgo de 2015-2023: provisión de 935 M y caso cerrado sin sanciones el 13-jul-2026 [5, 46].
- Demanda colectiva de valores por la guía de 2024, que sigue adelante tras la decisión de septiembre de 2026, y tres demandas derivadas contra consejeros [5].
- Dos guías anuales incumplidas seguidas (2024 y 2025) [12, 13].
- Venta del director financiero de 4,66 M USD el 22-oct-2026, al día siguiente de subir la guía [44].
- Salida del presidente de Carelon (mayo de 2026); el sucesor llegó en octubre [17, 45].

Parte IV — Mercado y valoración

15. Previsiones de la compañía y consenso

Confianza: Media

Guía de 2026 (21-oct-2026): BPA ajustado de al menos 29,00 USD (≥ 25,50 en enero, ≥ 26,75 en abril, ≥ 27,00 en julio), BPA contable de al menos 22,00 USD y flujo operativo de al menos 6.500 M [4]. La guía incluye partidas no operativas favorables; la «base» de 2026 sin ellas es de al menos 26,75 USD (26,00 en julio), y sobre ella la dirección promete un crecimiento del BPA ajustado de al menos el 12 % en 2027 (≥ 29,96 USD) [4]. Medicare Advantage con margen de al menos el 2 % en 2026 y objetivo del 3-5 %; Medicaid con objetivo del 2-4 % y 2026 como suelo. Detalle de 2027 en enero [4].

Periodo	Ingresos	EBITDA	EBIT	BPA	DPA	Fuente
2026e	198.740	10.538	9.396	29,08	6,86	BPA ajustado: S&P Global vía Stock Analysis [49]; ingresos, EBITDA, EBIT y DPA: MarketScreener [51]
2027e	203.604	10.798	9.679	30,22	7,21	BPA ajustado: S&P Global vía Stock Analysis [49]; resto: MarketScreener [51]
2028e	212.387	11.581	10.768	–	7,65	MarketScreener [51] (su BPA de 2028e, 32,82 USD, es contable y no se mezcla con el ajustado)

Nuestra proyección frente al consenso

Periodo	Ingresos propios	Ingresos consenso	Dif.	EBITDA propio	EBITDA consenso	Dif.
2026e	198.770	198.740	0,0 %	9.640	10.538	-8,5 %
2027e	204.733	203.604	+0,6 %	11.158	10.798	+3,3 %
2028e	213.536	212.387	+0,5 %	12.065	11.581	+4,2 %

Analistas	**22**	Comprar / mantener / vender	**14 / 8 / 0**
Precio objetivo medio	**481,48**	Rango de precios objetivo	**406,00 – 523,00**

Revisiones de estimaciones

Las estimaciones suben desde abril con cada subida de la guía: el BPA ajustado de 2026 pasa de ≈ 26,9 USD antes del 3T26 a 29,08, y el de 2027 a 30,22 (≈ 29,1 antes) [49]. Tras los resultados, TD Cowen subió su objetivo de 465 a 495 USD, Mizuho de 470 a 490, Goldman Sachs de 395 a 451 (Mantener), Truist de 475 a 500 y UBS de 460 a 523 [49]. El objetivo medio de S&P Global (22 analistas) es de 481,48 USD; el de MarketBeat (23, incluye objetivos más viejos) de 455,57 [49, 50]. MarketScreener solo da cifras contables (BPA de 22,43, 28,17 y 32,82 USD en 2026-2028) [51]. Las estimaciones de ingresos de 2026 (198.740 M) incluyen ya la pérdida de afiliados [51].

16. Comportamiento en bolsa

Confianza: Alta

Rentabilidad total (con dividendos).

Periodo	Acción	Índice	Sector
En el año	+27,3 %	+12,3 %	+17,2 %
1 año	+31,1 %	+13,4 %	+24,8 %
3 años (anual.)	+0,9 %	+24,1 %	+14,6 %
5 años (anual.)	+1,6 %	+12,2 %	+8,0 %
10 años (anual.)	+15,1 %	+15,3 %	+11,9 %



Beta (5 años, mensual)	**0,63**	Volatilidad anualizada (1 año)	**35,7 %**
Máxima caída (5 años)	**-50,4 %**	Posiciones cortas	**2,3 %**

Elevance sube un 27,3 % en 2026 (frente al 12,3 % del S&P 500 y el 17,2 % del sector) y un 31,1 % en un año, pero en tres años apenas gana un 0,9 % anual frente al 24,1 % del índice [48]. 2024 (−20,7 %) y 2025 (−3,1 %) fueron los años de las guías incumplidas. En 2026 cayó un 14,3 % el 27-ene con una guía floja y el aviso de tarifas de Medicare Advantage de 2027, y un 8,1 % el 2-mar con el aviso de sanciones de CMS; rebotó un 32,2 % en el mes hasta el 29-abr con la tarifa definitiva (+2,48 %) y la primera subida de guía [33, 46, 48]. Tras los resultados del 3T26 marcó un máximo de 52 semanas (450,69 USD intradía el 21-oct) y cierra el 23-oct a 439,95, un 21,8 % por debajo de su máximo histórico [48]. La beta mensual de cinco años (0,63) no recoge el riesgo regulatorio: la caída máxima en cinco años fue del −50,4 % (sep-2024 a ago-2025).

Precio y noticias antes de decidir (regla 13)

Variación 1 / 3 / 6 / 12 meses	**+10,5 % / +16,3 % / +27,6 % / +27,4 %**	Frente al máximo y al mínimo de 52 semanas	**-1,2 % / +56,7 %**
Frente al máximo de 5 años	**-21,8 %**	Tendencia (medias de 50 y 200 sesiones)	**alcista**
Volatilidad (60 sesiones)	**23,9 %**	Próximos resultados	**2027-01-27**
Veredicto	**no cambia**		

Periodo	Variación	Causa	Veredicto
ene-2026	-14,3 %	Guía de 2026 por debajo de lo esperado (BPA ajustado ≥ 25,50 USD) y aviso de tarifas de Medicare Advantage de 2027 casi plano (27-ene) [8, 34]	no cambia
mar-2026	-8,1 %	Aviso de sanciones de CMS por datos de riesgo de Medicare Advantage (2-mar); caso cerrado sin sanciones el 13-jul con una provisión de 935 M [5, 46]	no cambia
abr-2026	+32,2 %	Tarifa definitiva de Medicare Advantage de 2027 (+2,48 %) y primera subida de la guía con el 1T26 [7, 33]	no cambia
jul-2026	-9,7 %	Resultados del 2T26 (15-jul, −8,5 % en el día): guía subida pero ratio de prestaciones +80 pb por Medicaid y Medicare [6, 18]	no cambia

Fecha	Tipo	Hecho	Veredicto
2026-10-21	resultados	Resultados del 3T26: BPA ajustado de 6,99 USD frente a 4,71 de consenso (con 1,85 USD de beneficio no operativo neto), ratio de prestaciones del 90,6 % (−70 pb) y guía de 2026 subida a ≥ 29,00 USD; ≥ 12 % de crecimiento en 2027 sobre una base de 26,75 [4, 17].	no cambia
2026-10-22	directivos	El director financiero vende 10.584 acciones (4,66 M USD) sin plan 10b5-1; en julio compraron la consejera delegada (1,0 M) y el presidente (0,37 M) [44].	no cambia
2026-10-23	recomendación	Siete bancos suben el objetivo tras el 3T26 (UBS a 523, TD Cowen a 495, Guggenheim a 485, Barclays a 472, RBC a 455, Morgan Stanley a 449, Baird a 406), Mizuho lo fija en 490 y Goldman reitera «neutral» con 451 [50].	no cambia
2026-09-30	demanda o regulador	La demanda colectiva de valores por la guía de 2024 sigue adelante tras la decisión del juez de septiembre; demanda del Departamento de Justicia por datos de riesgo de la parte C en fase de pruebas hasta agosto de 2027 [5].	no cambia
2026-07-13	demanda o regulador	CMS cierra sin sanciones el caso de datos de riesgo de Medicare Advantage de 2015-2023; quedan 593 M de la provisión de 935 M por pagar [5].	no cambia

La subida de un 10,5 % en un mes y un 27,4 % en un año se explica por hechos publicados: tres subidas de guía, un ratio de prestaciones que baja y el sector entero al alza tras los resultados de UnitedHealth [4, 48]. No hay ampliaciones, colocaciones ni ofertas pendientes. La venta del director financiero es la noticia que más pesa en contra, pero es pequeña frente a las compras de julio de la consejera delegada y el presidente y no anticipa un dato [44]. Los hechos pendientes con fecha son el aviso de tarifas de Medicare Advantage de 2028 (finales de enero) y los resultados del 27-ene-2027 con la guía de 2027; la demanda del Departamento de Justicia no tiene fecha de decisión. Veredicto: no cambia.

17. Múltiplos frente a su historia

Confianza: Alta

Múltiplo	Actual	Mediana	Mínimo	Máximo	Percentil	Prima / descuento
EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)	11,8x	11,0x	9,1x	13,2x	60 %	+7 %
PER últimos 12 meses (cierre de cada año)	18,7x	18,6x	13,9x	21,1x	80 %	+1 %

A 439,95 USD, Elevance cotiza a 11,8 veces el EBITDA de los últimos doce meses, un 7 % por encima de su media de cinco años (11,0x, percentil 60), y a 18,7 veces el beneficio contable, en su media (18,6x). Sobre el BPA ajustado de 2027e (30,49 USD), el PER es de 14,4 veces, en la mediana adelantada de cinco años (14,3x) y por encima de la de 2024-2025 (12,1-12,2x), cuando el mercado dudaba del margen [8, 12]. Con ese múltiplo la acción ya no está barata frente a su historia: la rebaja de 2024-2025 se ha cerrado con la recuperación de 2026. Lo estructural no ha cambiado a mejor: el riesgo regulatorio de Medicaid y Medicare Advantage es mayor que en 2021-2022, cuando cotizaba a 16 veces el beneficio adelantado, y los tipos de interés son más altos.

18. Comparables cotizados

Confianza: Media

Las seis grandes aseguradoras de salud gestionada cotizadas en EE. UU. (UnitedHealth, Cigna, CVS Health con Aetna, Humana, Centene y Molina), con la misma mezcla de primas de Medicare Advantage, Medicaid y planes de empresa, y dos aseguradoras pequeñas de crecimiento (Oscar en el ACA y Alignment en Medicare Advantage), las mismas del informe de UnitedHealth del 18-oct [64]. Cigna, CVS y UnitedHealth suman gestión de farmacia como CarelonRx. Se usa sobre todo el PER: el valor empresa de Stock Analysis resta la caja de las filiales reguladas y no es comparable [52].

Empresa	País	Capitaliz.	EV/Vtas	EV/ EBITDA LTM	EV/ EBITDA NTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC	DN/ EBITDA	FCF yield
Elevance	US	95.513	0,6x	11,8x	11,6x	14,7x	+1,7 %	5,3 %	11,3 %	2,7x	6,8 %
UnitedHealth Group	US	375.280	0,9x	14,7x	–	18,4x	+3,0 %	6,4 %	12,4 %	2,5x	6,1 %
The Cigna Group	US	81.110	0,4x	8,3x	–	9,7x	+5,0 %	4,5 %	13,4 %	1,9x	11,2 %
CVS Health	US	119.550	0,4x	10,9x	–	11,5x	+3,6 %	4,0 %	7,2 %	3,7x	9,8 %
Humana	US	50.680	0,4x	16,3x	–	34,0x	+14,8 %	2,5 %	8,1 %	2,2x	3,9 %
Centene	US	34.660	0,1x	5,8x	–	15,1x	+7,3 %	2,6 %	8,8 %	-2,4x	25,8 %
Molina Healthcare	US	10.890	0,3x	29,5x	–	25,9x	+11,2 %	0,9 %	3,3 %	-2,6x	2,2 %
Oscar Health	US	9.560	0,4x	9,1x	–	17,0x	+32,7 %	4,3 %	25,1 %	-5,5x	45,8 %
Alignment Healthcare	US	1.670	0,3x	15,0x	–	14,6x	+35,8 %	1,9 %	9,9 %	-4,2x	10,6 %

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

Estadístico	EV/Vtas	EV/EBITDA LTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC
Mediana	0,4x	12,8x	16,1x	+9,3 %	3,3 %	9,4 %
Media	0,4x	13,7x	18,3x	+14,2 %	3,4 %	11,0 %
Percentil 25	0,3x	8,9x	13,8x	+4,7 %	2,4 %	7,9 %
Percentil 75	0,4x	15,3x	20,3x	+19,3 %	4,4 %	12,7 %

Valor implícito por acción

Múltiplo aplicado	Métrica de la empresa	Múltiplo p25 / mediana / p75	Valor p25	Valor mediana	Valor p75	Potencial
EV/EBITDA últimos 12 meses	10.543	8,9x / 12,8x / 15,3x	298,93	488,33	610,95	+11,0 %
PER próximos 12 meses	30,0	13,8x / 16,1x / 20,3x	414,94	481,72	608,53	+9,5 %
EV/Ventas últimos 12 meses	199.071	0,3x / 0,4x / 0,4x	123,47	215,17	242,68	-51,1 %



Elevance cotiza a 14,7 veces el beneficio de los próximos doce meses, por debajo de la mediana del grupo (16,1x) y en medio de las dos referencias limpias: UnitedHealth (18,4x, con Optum y un ROIC del 12,4 %) y Cigna y CVS (9,7-11,5x, con más peso de farmacia) [53, 54, 55]. Humana (34,0x) y Molina (25,9x) tienen el beneficio de 2026 hundido y empujan la media; Oscar y Alignment crecen más del 30 % y no son comparables por tamaño [56, 58, 59, 60]. El PER mediano aplicado a su BPA de los próximos doce meses (30,01 USD) da 481,72 USD, un 9,5 % por encima del precio. El descuento frente a la mediana se justifica a medias: su ROIC (11,3 %) supera la mediana del grupo (9,4 %), pero crece

menos (1,7 % de ingresos a doce meses frente a 9,3 %). El EV/EBITDA no compara porque Stock Analysis resta la caja regulada de las aseguradoras; usamos solo el PER, con un peso del 15 %.

19. Transacciones precedentes

Confianza: Media

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2018-03	Express Scripts	Cigna	67.000	0,67x	9,2x	31 %	48,75 USD en efectivo + 0,2434 acciones por acción (54.000 M en total) y 15.000 M de deuda asumida; prima del 31 % sobre el cierre de 73,42 USD del 7-mar-2018 [65]. Múltiplos sobre 2017: ingresos 100.065 M y EBITDA 7.296 M (resultado operativo 5.494 + amortizaciones 1.802) [70] (cálculo propio).
2017-12	Aetna	CVS Health	77.000	1,27x	–	–	145 USD en efectivo + 0,8378 acciones de CVS por acción, ≈ 207 USD por acción y 69.000 M de capital; 77.000 M con la deuda asumida [66]. EV/ventas sobre los ingresos de 2017 de Aetna, 60.535 M [71] (cálculo propio).
2021-01	Change Healthcare	UnitedHealth Group (Optum)	12.521	4,05x	18,1x	–	25,75 USD por acción en efectivo [67]. Estimación propia del valor empresa: 304,45 M de acciones (27-oct-2020) × 25,75 = 7.840 M + deuda 4.818 M − caja 137 M (31-dic-2020) [72]. Múltiplos sobre el ejercicio cerrado en marzo de 2021: ingresos 3.090 M y EBITDA 691 M (resultado operativo 100 + amortizaciones 591) [72].
2023-06	Amedisys	UnitedHealth Group (Optum)	3.694	1,66x	17,9x	–	101 USD por acción en efectivo [68]. Estimación propia del valor empresa: 32,56 M de acciones × 101 = 3.289 M + deuda 400 M − caja 49 M + minoritarios 54 M (31-mar-2023) [73]. Múltiplos sobre 2022: ingresos 2.223 M y EBITDA 206 M (resultado operativo 181 + amortizaciones 25) [73].

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2022-09	Signify Health	CVS Health	8.000	12,30x	67,8x	–	30,50 USD por acción en efectivo; valor total de la operación ≈ 8.000 M [69]. Sobre 2021: ingresos 653 M y EBITDA 118 M [74] (cálculo propio). Plataforma de evaluaciones domiciliarias en crecimiento: múltiplo no comparable con un asegurador.
2023-02	Oak Street Health	CVS Health	10.600	–	–	–	39 USD por acción en efectivo, valor empresa ≈ 10.600 M; red de atención primaria con EBITDA ajustado aún negativo, que CVS espera que aporte más de 2.000 M de EBITDA ajustado «embebido» en madurez [75].
2021-04	Kindred at Home (60 % restante)	Humana	8.100	–	–	–	Valor empresa de 8.100 M para el 100 %, incluidos 2.400 M del 40 % que Humana ya tenía; 43.000 cuidadores y más de 550.000 pacientes al año [76]. La nota no publica ingresos ni EBITDA.
2024-01	Blue Cross and Blue Shield de Luisiana (retirada)	Elevance Health	–	–	–	–	Compra anunciada en 2023 y retirada en 2024 sin precio publicado comparable; muestra el interés de Elevance por sumar licencias Blue, no un múltiplo.

EV/EBITDA mediano (p25 – p75)	**17,9x (13,6x – 18,0x)**	Prima de control mediana	**31 %**
Valor por acción implícito (mediana de EV/EBITDA)	**736,00**	Rango p25 – p75	**524,75 – 740,86**



Las compras de referencia del sector se han pagado a 9-18 veces el EBITDA: 9,2x por Express Scripts (Cigna, 2018) y 17,9-18,1x por Amedisys y Change Healthcare (UnitedHealth) [65, 67, 68]. Son negocios de farmacia y servicios, no aseguradoras enteras, y llevan prima de control (31 % en Express Scripts). La mediana da 736,00 USD por acción, pero no la ponderamos: Elevance es licenciataria de Blue Cross Blue Shield, cuyas reglas impiden en la práctica una compra por un tercero, y con 95.513 M de capitalización no hay comprador plausible. Sirve de contraste para Carelon en la suma de partes. La compra de Blue Cross Blue Shield de Luisiana (2024) se retiró sin precio publicado y queda excluida.

20. Descuento de flujos de caja (DCF)

Confianza: Media

Supuestos y su justificación

Crecimiento de ingresos.

2026e se fija en el +0,6 % (198.770 M): 149.760 M de ingresos operativos en nueve meses (+1,0 %) y un 4T parecido al de 2025, frente a 198.740 M de consenso [4, 51]. La empresa ha elegido margen frente a volumen: Medicare Advantage −15,5 % de afiliados en un año y salidas de mercados de Medicaid y del ACA [4]. 2027e (+3,0 %) queda un 0,6 % por encima del consenso (203.604 M): la tarifa de Medicare Advantage sube un 2,48 % y las primas comerciales se han fijado con una tendencia de coste elevada, pero Medicaid pierde afiliados con los requisitos de trabajo [17, 33]. 2028e (+4,3 %) coincide con el consenso (212.387 M) [51]; después, 4,5 % y una bajada al 3,5 % en 2032e, por debajo del gasto sanitario de EE. UU. (≈ 5,6 % anual previsto por CMS) y del 9,6 % anual de 2021-2025, que incluía compras y la subida de Medicaid tras la pandemia [26].

Márgenes.

El margen EBITDA de 2026e (4,85 %, 9.640 M) sale de 7.296 M de EBIT en nueve meses (5.118 M de resultado de los segmentos más 2.506 M de renta de inversiones menos 328 M de amortización de intangibles) y un 4T estacionalmente flojo, con ≈ 1.490 M de amortizaciones [4]. Incluye la provisión de CMS (935 M) y ≈ 530 M de renta de inversiones no recurrente. El consenso (10.538 M) es un EBITDA ajustado, sin la provisión [51]. 2027e (5,45 %) es coherente con la promesa de BPA ajustado ≥ 29,96 USD (nuestro 30,49); el margen sube al 6,0 % en 2031e, por debajo del 6,8-7,3 % de 2021-2024 (sin partidas no recurrentes). La palanca es el ratio de prestaciones: 90,0 % en 2025 y 90,6 % en el 3T26 (−70 pb), con Medicare Advantage hacia un margen del 3-5 % y Medicaid del 2-4 % desde un suelo en 2026 [1, 4, 17]. Cada punto de margen EBITDA vale ≈ 125 USD por acción (estimación propia).

Inversión y circulante.

Elevance invierte poco en activos: capex del 0,6-0,8 % de las ventas en 2021-2025 (1.116 M en 2025) [1]. Al capex sumamos el capital estatutario que las filiales reguladas deben retener cuando crecen las primas (≈ 11 % del aumento de ventas): el capex del DCF sube al 1,0-1,1 % de las ventas desde 2027e. El circulante (7,2 % de las ventas: cuentas a cobrar a CMS, estados y clientes menos proveedores) se mantiene constante; las reservas médicas quedan fuera porque respaldan la caja regulada, que también excluimos del puente [5]. Es conservador: las reservas crecen con las primas y financiarían parte de ese circulante. Amortizaciones del 0,75 % de las ventas (la de intangibles bajó a 106 M por trimestre). Tipo impositivo del 23 %, el de nueve meses de 2026 y de 2023-2024.

Coste del capital.

Tasa libre: bono de EE. UU. a 10 años al 5,00 % (23-oct-2026, Tesoro) [61]. Beta de 0,92: la desapalancada de Damodaran para servicios sanitarios (≈ 0,74) reapalancada con la deuda de Elevance (deuda sobre capitalización de 0,32 y un 23 % de impuestos) [63]. No usamos la de la acción (0,63 mensual a cinco años; 0,43 semanal a dos años) porque no recoge el riesgo regulatorio que sí mostró la caída del −50,4 % en 2024-2025 [48]. Prima de mercado del 5,5 %; la implícita de Damodaran (4,20 %) va en la regla relativa [62]. Coste de la deuda del 5,0 % antes de impuestos (intereses de 358 M en el 3T26 sobre 30.757 M de deuda, 4,7 %, y emisiones recientes por encima) [4, 5]. Peso de la deuda del 24,4 % (30.757 M sobre 30.757 + 95.050 M). WACC del 8,54 %. El informe del 14-oct usaba una beta de 0,85, la de UnitedHealth, con menos deuda.

Valor terminal.

Media de Gordon (crecimiento del 3,0 %, inflación de largo plazo y algo de crecimiento real del gasto sanitario, por debajo de la tasa libre) y un múltiplo de salida de 9 veces el EBITDA, por debajo de la media de cinco años (11,0x) y del 9,1-9,8x de 2024-2025, sus mínimos [25]. El múltiplo implícito del valor terminal es de 10,9 veces y pesa el 72 % del valor empresa.

Coste medio ponderado del capital

Componente	Valor
Tasa libre de riesgo	5,00 %
Beta	0,92
Prima de riesgo de mercado	5,50 %
Prima adicional (país, tamaño, específica)	0,00 %
Coste de los fondos propios	10,06 %
Coste de la deuda antes de impuestos	5,00 %
Tipo impositivo	23,00 %
Coste de la deuda después de impuestos	3,85 %
Peso de la deuda (D / (D + E))	24,40 %
WACC	8,54 %
Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa)	4,20 %
WACC con la prima implícita del mercado	7,64 %

Proyección

Año	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	Amort.	Impuestos	Capex	Δ Circ.	FCFF	Fracción	VA
2026e	198.770	0,6 %	9.640	4,9 %	1.491	1.874	1.193	91	6.482	0,18	1.163
2027e	204.733	3,0 %	11.158	5,5 %	1.535	2.213	1.945	429	6.570	1,00	6.210
2028e	213.536	4,3 %	12.065	5,7 %	1.602	2.407	2.349	634	6.675	1,00	5.815
2029e	223.145	4,5 %	12.942	5,8 %	1.674	2.592	2.499	692	7.160	1,00	5.742
2030e	233.187	4,5 %	13.875	6,0 %	1.749	2.789	2.612	723	7.751	1,00	5.728
2031e	242.514	4,0 %	14.551	6,0 %	1.819	2.928	2.595	672	8.356	1,00	5.689
2032e	251.002	3,5 %	15.060	6,0 %	1.883	3.031	2.560	611	8.858	1,00	5.559

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.



Valor terminal

Concepto	Valor
Método principal	Media de ambos
Crecimiento a perpetuidad	3,0 %
Múltiplo EV/EBITDA de salida	9,0x
Valor terminal (Gordon)	164.546
Valor terminal (múltiplo)	135.541
Múltiplo de salida implícito en Gordon	10,9x
Crecimiento implícito en el múltiplo	1,89 %
Peso del valor terminal en el valor empresa	72 %

Del valor empresa al valor por acción

Concepto	Importe
Valor actual de los flujos proyectados	35.906
Valor actual del valor terminal	90.382
Valor empresa	126.288
– Deuda financiera neta (con arrendamientos)	-28.341
– Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas	-593
Valor de los fondos propios	97.354
Acciones diluidas (millones)	217,1
Valor por acción	448,43

Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

WACC	2,0 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %
7,5 %	475,32	500,34	530,86	568,92	617,72
8,0 %	441,30	461,68	486,10	515,89	553,05
8,5 %	411,67	428,53	448,43	472,27	501,36
9,0 %	385,55	399,67	416,13	435,56	458,84
9,5 %	362,25	374,22	388,01	404,09	423,06

Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

Margen \ crec.	-2 pp	-1 pp	0 pp	+1 pp	+2 pp
-2 pp	191,96	201,57	211,41	221,48	231,78
-1 pp	299,18	314,31	329,92	346,02	362,63
0 pp	406,41	427,05	448,43	470,57	493,48
+1 pp	513,63	539,79	566,94	595,11	624,33
+2 pp	620,86	652,53	685,45	719,65	755,18

¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

Veredicto: En parte.

Prueba	Valor
Crecimiento medio de ingresos proyectado	3,5 %
Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión)	1,0 % de las ventas
Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante)	7.852 M (13 % del NOPAT)
Con la reinversión bruta (capex + circulante): crecimiento que financia al ROIC actual	3,7 % (reinvierte el 33 % del NOPAT)
Rendimiento que la proyección supone para la reinversión bruta	13,9 % (histórico: 6,3 %)
Crecimiento histórico de ingresos (TCAC)	9,6 % frente al 3,5 % proyectado
Veredicto de las pruebas del motor	Sí

La proyección apenas necesita inversión neta de la amortización (reinversión acumulada de 7.852 M, el 13 % del NOPAT, con un capex bruto medio del 1,0 % de las ventas). En un negocio de activos ligeros, el crecimiento medio del 3,5 % tiene que salir de subir precios y de ganar volumen sin capital nuevo, y la prueba es el poder de precios y la cuota; en un comprador en serie, la amortización es de intangibles comprados y la prueba es el capex bruto (las compras) frente al crecimiento comprado.

Año	Volumen	Precio	Otros (mezcla, compras)	Crecimiento	De dónde sale
2026e	-4,5 %	+5,1 %	0,0 %	+0,6 %	Volumen: 44,9 M de afiliados médicos a septiembre frente a 45,6 M en diciembre, con Medicare Advantage −15,5 % en un año y salidas de mercados de Medicaid y del ACA [4, 5]. Precio: tarifas de Medicaid al alza (1-jul), tarifa de Medicare Advantage de 2026 del +5,06 % y primas comerciales subidas [17, 35]. CarelonRx y Carelon Services crecen un 5-8 % [4].
2027e	-2,0 %	+5,0 %	0,0 %	+3,0 %	Volumen: requisitos de trabajo de Medicaid de la ley H.R. 1 desde 2027 y fin de los subsidios reforzados del ACA; la dirección no da afiliados de 2027 [5, 17]. Precio: tarifa de Medicare Advantage de 2027 del +2,48 % (≈ 5 % con la tendencia de riesgo) y primas comerciales con una tendencia de coste elevada [17, 33].
2028e	0,0 %	+4,3 %	0,0 %	+4,3 %	Volumen estable: termina la poda de mercados y Carelon sigue creciendo con terceros. Precio en línea con el gasto sanitario por persona [25, 26].
2029e	+0,5 %	+4,0 %	0,0 %	+4,5 %	Por debajo del gasto sanitario nacional previsto por CMS (≈ 5,6 % anual) [26].
2030e	+0,5 %	+4,0 %	0,0 %	+4,5 %	Igual que 2029e; Elevance tiene ≈ 12 % del seguro comercial y ≈ 5 % de Medicare Advantage, sin margen de ganancia de cuota grande [27, 37].

En parte. La prueba financiera pasa (la reinversión que proyectamos financia un 3,7 % de crecimiento frente al 3,5 % proyectado), pero dos señales no acompañan: el ROIC incremental de 2021-2025 es del 6,3 %, por debajo del WACC (8,54 %), y la cuota cae por decisión propia en Medicare Advantage (−15,5 % de afiliados en un año) y en Medicaid [4]. El poder de precio sí existe: el ratio de prestaciones bajó 70 pb en el 3T26 con ingresos planos, y en la campaña comercial de 2027 volvieron grandes empleadores [4, 17]. Prueba de cuota a mano: los ingresos de 2025 equivalen al 3,5 % del gasto sanitario de EE. UU.; con un crecimiento del 3,5-4,5 % frente al 5,6 % del gasto, la cuota de 2030e sería menor (estimación propia) [26]. El caso base no pide ganar cuota: lo exigente es devolver el margen al 6,0 %.

DCF inverso: qué descuenta el precio actual

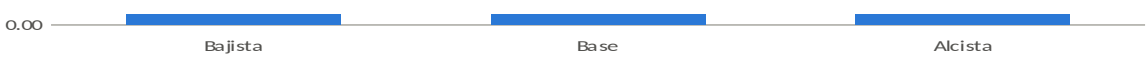
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2032e)	**3,6 % (base: 4,0 %)**
Margen EBITDA final implícito	**5,9 % (base: 6,0 %)**
Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual)	**8,7 % (WACC: 8,5 %)**

El DCF da 448,43 USD por acción, un 1,9 % por encima del precio, con un WACC del 8,54 % y un valor terminal que pesa el 72 %. Baja desde 465,14 USD en el informe del 14-oct por la beta (0,92 frente a 0,85) y por el circulante, que ahora se mantiene en su nivel real; sube por el margen de 2026-2027 (la guía pasó de ≥ 27,00 a ≥ 29,00 USD) y por una tasa libre algo menor (5,00 % frente a 5,22 %). El DCF inverso dice que el precio de 439,95 USD descuenta un crecimiento anual del 3,6 % en 2027e-2032e (frente a nuestro 4,0 %) o, con nuestro crecimiento, un margen EBITDA final del 5,9 % (frente a nuestro 6,0 %): rinde un 8,7 % anual, 0,2 puntos más que nuestro coste de capital. El mercado paga casi toda la recuperación que esperamos. Con la prima implícita del mercado (4,20 %) el DCF sube a 521,63 USD: la distancia entre valor y precio es de tasa de descuento, no de cifras. La variable que decide es el ratio de prestaciones: cada punto de margen EBITDA vale unos 125 USD por acción.

21. Escenarios

Confianza: Media

Escenario	Prob.	Crec. medio	Margen final	WACC	Valor	Potencial	Qué tiene que ocurrir
Bajista	25 %	2,0 %	5,2 %	9,0 %	295,73	-32,8 %	El coste médico de Medicaid y del comercial sigue por delante de las tarifas, los estados no compensan la cartera más enferma que dejan los requisitos de trabajo y la renta de inversiones vuelve a su nivel normal. El margen EBITDA se queda ≈ 0,8 puntos por debajo del base (≈ 5,2 % en 2030, el de 2025), los ingresos crecen 2 puntos menos al año y el mercado exige más prima. Es lo que pasó en 2024-2025.
Base	50 %	4,0 %	6,0 %	8,5 %	448,43	+1,9 %	Se cumple la guía de 2026 (BPA ajustado ≥ 29,00 USD) y el +12 % de 2027 sobre la base de 26,75 (≥ 29,96); Medicare Advantage sube del 2 % al 3-5 % de margen y Medicaid sale del suelo de 2026. El margen EBITDA llega al 6,0 % en 2031, por debajo del 6,8-7,3 % de 2021-2024, con ingresos al 3-4,5 % anual, menos que el gasto sanitario.
Alcista	25 %	5,0 %	6,4 %	8,5 %	520,38	+18,3 %	Medicaid vuelve al 2-4 % de margen con tarifas actualizadas por los estados, Carelon crece con terceros y la eficiencia (IA en siniestros y autorizaciones) baja el ratio de gastos: el margen supera en 0,4 puntos al base y los ingresos crecen un punto más con el envejecimiento y nuevas licitaciones.



Valor ponderado por probabilidad: 428,24 USD (-2,7 %).

La asimetría con nuestro coste de capital es de 0,56 veces: el alcista gana un 18,3 % (520,38 USD) y el bajista pierde un 32,8 % (295,73 USD), y el valor ponderado (428,24 USD) queda un 2,7 % por debajo del precio. El bajista no es cosmético: es el margen de 2025 (≈ 5,2 %) mantenido, algo que la empresa ya vivió en 2024-2025 con dos guías incumplidas. Con la prima implícita del mercado, la asimetría sube a 1,70 veces. Para quien exija nuestro 8,54 %, el

perfil no compensa; para quien se conforme con lo que hoy pide el mercado (7,64 %), es aceptable pero no da para comprar.

22. Suma de partes

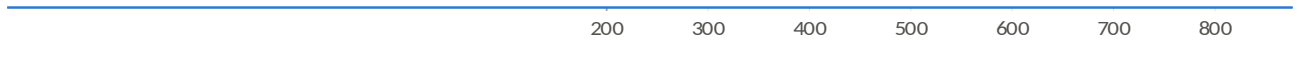
Confianza: Media

Con resultados normalizados por segmento (estimación propia a partir de los nueve meses de 2026 y de 2023-2025) y múltiplos de cada negocio, la suma de partes da 396,67 USD por acción, un 9,8 % por debajo del precio. Health Benefits vale la mitad del valor empresa (57.200 M), CarelonRx y Carelon Services el 36 % y la renta de inversiones neta de gastos corporativos el resto. La lectura: el precio ya paga algo más que un Health Benefits a mitad de camino de su margen de 2023-2024. No aplicamos descuento de conglomerado: los negocios comparten clientes (las eliminaciones internas suman 35.320 M en nueve meses) [4]. Pesa un 10 % en la síntesis porque los resultados normalizados son estimaciones propias.

Negocio	Métrica	Valor de la métrica	Múltiplo	Valor empresa	Justificación del múltiplo
Health Benefits	Resultado operativo ajustado normalizado (estimación propia)	5.200	11,0x	57.200	3.489 M de resultado operativo en nueve meses de 2026 (2,7 % de margen) y 4.158 M en 2025, frente a 6.243-6.888 M en 2023-2024 [1, 4]. Normalizamos en 5.200 M (≈ 3,2 % de margen sobre ≈ 162.000 M de ingresos, la mitad del camino hacia 2023-2024) y aplicamos 11 veces, el EV/EBITDA de CVS y por encima de Cigna (8,3x) [54, 55]. Sin la renta de inversiones, que va aparte.
CarelonRx	Resultado operativo 2026e (estimación propia)	2.350	10,0x	23.500	1.780 M en nueve meses (5,3 % de margen) y 2.418 M en 2025 [1, 4]; 2026e ≈ 2.350 M. Express Scripts se compró a 9,2 veces el EBITDA y Cigna cotiza a 8,3 veces [54, 65]; 10 veces por la farmacia de especialidad y la infusión (BioPlus, Paragon), a pesar de la reforma de los gestores de farmacia [38].
Carelon Services	Resultado operativo 2026e (estimación propia)	1.350	13,0x	17.550	1.128 M en nueve meses (4,9 % de margen) y 960 M en 2025, con un 3T26 +33 % [1, 4]. 13 veces: servicios de salud conductual, domicilio (CareBridge) y especialidades con terceros, por debajo de los 17,9-18,1 veces pagados por Amedisys y Change Healthcare [67, 68, 72, 73].
Renta de inversiones (cartera regulada, neta de gastos corporativos)	Renta normal de inversiones menos gastos corporativos (estimación propia)	2.100	8,0x	16.800	Renta de inversiones de 2.506 M en nueve meses, con ≈ 530 M de ajustes de valoración no recurrentes; normal ≈ 2.600 M al año, menos ≈ 500 M de gastos corporativos [4, 17]. 8 veces: depende de los tipos de interés y de una cartera que respalda reservas y capital estatutario.

Valor por acción por suma de partes: 396,67 (-9,8 %); con ±1x en los múltiplos, 317,17 – 476,16.

23. Síntesis de valoración



Método	Mínimo	Central	Máximo
Cotización 52 semanas	274,84	439,95	450,69
Precio objetivo de los analistas	406,00	481,48	523,00
Comparables: PER NTM	414,94	481,72	608,53
Transacciones precedentes (EV/EBITDA)	524,75	736,00	740,86
DCF (WACC y g ± 0,5)	399,67	448,43	515,89
Escenarios (bajista – alcista)	295,73	428,24	520,38
Suma de partes	317,17	396,67	476,16
DCF con la prima del mercado	478,39	521,63	573,93
Precio actual	437,75	439,95	442,15

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	448,43	+1,9 %	40 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	481,72	+9,5 %	15 %
Transacciones precedentes (no se usa)	736,00	+67,3 %	0 %
Suma de partes	396,67	-9,8 %	10 %
Escenarios ponderados	428,24	-2,7 %	35 %

Valor intrínseco ponderado (largo plazo): 441,18 USD (+0,3 % sobre 439,95).

El puente es el balance de 30-sep-2026 del 10-Q: deuda de 30.757 M (toda a largo plazo), sin minoritarios relevantes, y solo 2.416 M de caja, la de la matriz [5]. Es la decisión clave, como en UnitedHealth: la caja consolidada (10.348 M) y la cartera de inversiones respaldan las reservas médicas y el capital estatutario, y su rendimiento ya está en el EBITDA; contarla añadiría ≈ 37 USD por acción (estimación propia). En otros ajustes van los 593 M pendientes de pago de la provisión de CMS [5]. Sin arrendamientos: en US GAAP los operativos no son deuda. Pesos: DCF 40 % y escenarios 35 %, porque el valor depende de la recuperación del margen; comparables (PER) un 15 % y suma de partes un 10 %, porque miden un 2026 aún deprimido o estimaciones propias; transacciones 0 %, porque no hay comprador posible. El valor objetivo (441,18 USD) apenas supera el precio.

Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

Escenario	BPA	PER	De dónde sale el PER	Precio	Rentabilidad
Bajista	26,23	11,5x	base × 0.8	301,65	-29,9 %
Base	33,47	14,3x	PER actual (14.4x) a mitad de camino hacia abajo, hacia la mediana de 5 años (14.3x)	478,62	+10,4 %
Alcista	37,28	16,1x	mediana de los comparables	600,21	+38,0 %

Objetivo a 12 meses (ponderado): 464,78 USD · rentabilidad +7,2 % (base +10,4 %) · señal Mantener.

Para comparar, con la regla v2 (historia al cierre, mismo precio): 11,2x / 14,2x / 16,1x, 6,4 % Mantener. Decide la v3 con tope ×1,1, elegida por el selector de método (sin marcas: decide la v3; METODO-VIGENTE.md).

Frente al consenso (solo contraste).

Nuestro BPA ajustado de 2027e (30,49 USD) supera en un 0,9 % al consenso (30,22) y a la promesa de la empresa (≥ 29,96) [4, 49]; no hay consenso ajustado de 2028e (el de MarketScreener, 32,82, es contable), pero nuestro EBITDA de 2028e (12.065 M) queda un 4,2 % por encima del de consenso (11.581 M) [51]. Nuestro precio base (478,62 USD)

queda un 0,6 % por debajo del objetivo medio de los analistas (481,48, 22 analistas, con subidas en la semana de resultados) [49, 50]: la diferencia es pequeña y sale del múltiplo (14,3x, la mediana de cinco años), no del BPA.

Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.

El objetivo a 12 meses (464,78 USD, ponderado; +7,2 % con dividendo; base 478,62, +10,4 %) queda un 5 % por encima del valor intrínseco (441,18 USD). La distancia es pequeña: el mercado puede pagar dentro de un año el PER de hoy sobre un BPA de 2028e un 10 % mayor que el de 2027e, pero el DCF, con nuestro coste de capital, apenas ve valor por encima del precio. La asimetría es pobre porque el bajista aplica 11,5 veces (base × 0,80) a un BPA de margen hundido. Lo que subiría la cifra sería un precio más bajo, no un catalizador.

Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

24. Catalizadores

Confianza: Media

Fecha	Evento	Qué se sabrá	Prob.	Sentido
15-oct a 7-dic-2026	Inscripción abierta de Medicare Advantage para 2027	Primera lectura de afiliados de 2027; la dirección ha recortado planes con pérdidas y espera otro año de menos afiliados con más margen [17]	Alta	+/–
27-ene-2027	Resultados de 2026 y guía de 2027	Confirma o no el ≥ 12 % de crecimiento del BPA ajustado (≥ 29,96 USD); nuestro base usa 30,49 [4, 50]	Alta	+/–
Finales de enero de 2027	Aviso de tarifas de Medicare Advantage para 2028 (CMS)	El aviso de 2027 casi plano costó un −14,3 % en un día; la tarifa definitiva llega en abril [33, 34, 48]	Alta	+/–
1-ene-2027 en adelante	Requisitos de trabajo de Medicaid (ley H.R. 1) y tarifas estatales de 2027	Menos afiliados de Medicaid y cartera más enferma; las tarifas de los estados deciden si Medicaid sale del suelo de margen de 2026 [5, 17]	Alta	–
Hasta ago-2027 (pruebas periciales)	Demanda del Departamento de Justicia por datos de riesgo de Medicare Advantage	Riesgo de multa o acuerdo; sin cuantificar por la empresa [5]	Media	–
Sin fecha	Recompras con la autorización pendiente de 5.007 M	La dirección será «oportunista» en 2027; cada 1.000 M recompra ≈ 1 % de las acciones [5, 17]	Media	+

25. Riesgos y pre-mortem

Confianza: Media

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Efecto en valor	Mitigante	Señal de alerta
1	**Coste médico por encima de las primas en Medicaid y comercial: el ratio de prestaciones vuelve al 91-92 % y Medicaid no sale del suelo de 2026**	Operativo	Media	Alto	−33 % en el escenario bajista; ≈ −125 USD por acción por punto de margen EBITDA (estimación propia)	Tarifas de Medicaid actualizadas el 1-jul y precios comerciales de 2027 fijados con una tendencia de coste elevada [17]	Ratio de prestaciones anual por encima del 91 % o margen de Medicaid de 2027 por debajo de cero
2	**Regulación de Medicaid (requisitos de trabajo y financiación de la ley H.R. 1) y fin de los subsidios reforzados del ACA**	Regulatorio	Alta	Medio	−5 a −10 % (estimación propia: −2 puntos de crecimiento y 0,3 puntos de margen)	Salida de mercados con pérdidas y tarifas estatales ajustadas a la nueva cartera [5, 17]	Afiliados de Medicaid por debajo de 7,5 M en 2027
3	**Tarifas y ajuste de riesgo de Medicare Advantage (V28, estrellas) más duros en 2028**	Regulatorio	Media	Medio	−5 a −8 % (0,3-0,5 puntos de margen)	Medicare Advantage es ≈ 1,9 M de afiliados y la empresa prioriza margen sobre volumen [4]	Aviso de tarifas de 2028 por debajo del +2 %
4	**Demanda del Departamento de Justicia por la Ley de Reclamaciones Falsas (datos de riesgo de la parte C) y demanda colectiva de valores**	Legal	Media	Medio	Multa no cuantificable; 1.000 M serían ≈ −4,6 USD por acción	CMS cerró sin sanciones su propio caso de 2015-2023 en julio [5]	Acuerdo o sentencia; provisiones nuevas en el 10-Q
5	**Calidad del beneficio: la renta de inversiones de 2026 lleva ajustes de valoración no recurrentes y los días de reservas bajan**	Financiero	Media	Bajo	−1,85 USD de BPA si no se repiten (ya excluidos de 2027e)	La dirección separa la base de 26,75 USD sin ellos [4, 17]	Días de reservas por debajo de 42 o desarrollo desfavorable de reservas
6	**Arbitrajes de facturación (ley No Surprises) y reforma de los gestores de farmacia**	Regulatorio	Media	Bajo	−2 a −4 %	669 M ya reconocidos como pasivo; CarelonRx crece con la farmacia de especialidad [5, 38]	Margen de CarelonRx por debajo del 4,5 %
7	**Licencia de Blue Cross Blue Shield: restricciones de marca y de control que limitan la expansión y cualquier operación corporativa**	Gobierno	Baja	Medio	Sin efecto directo; quita la opción de compra por un tercero	La marca Blue da escala local en 14 estados [1]	Cambios en las reglas de la asociación Blue tras el acuerdo antimonopolio de 2024

Pre-mortem

Octubre de 2029: la acción vale 280 USD y ha perdido un 36 %. La recuperación de 2026 fue en parte de inversiones: los ajustes de valoración (1,85 USD por acción solo en el 3T26) no se repitieron y el margen operativo de Health Benefits se quedó por debajo del 3 %. Los requisitos de trabajo de Medicaid sacaron a los afiliados sanos y los estados tardaron dos años en ajustar las tarifas; Medicaid siguió en pérdidas en 2027 y 2028. El aviso de tarifas de Medicare Advantage de 2028 vino casi plano, la tendencia comercial siguió alta con los fármacos GLP-1 y los arbitrajes de facturación, y el Departamento de Justicia cerró su demanda con un acuerdo de más de 1.000 M. El BPA ajustado se quedó en 28-29 USD en 2027-2028, la dirección incumplió por tercera vez su promesa de crecimiento y el mercado volvió a pagar 11-12 veces el beneficio, como en 2024-2025. Lo habrían anticipado el margen de Medicaid de 2027, el ratio de prestaciones del 1T27 y el aviso de tarifas de enero de 2027.

Riesgo de inteligencia artificial

Exposición: Media · **Sentido:** Mixto · **Efecto en valor (3-5 años):** +3 % a 3-5 años (estimación propia: ≈ 0,2 puntos de margen EBITDA en gastos operativos), con riesgo regulatorio sobre el uso de algoritmos

La IA toca sobre todo los costes: los gastos operativos son el 11,4 % de los ingresos (5.752 M en el 3T26) y buena parte es trabajo administrativo que se puede automatizar (siniestros, autorizaciones previas, atención al cliente, codificación) [4]. La dirección cita inversiones en tecnología que explican parte de la subida del gasto operativo de 2026 (+13,2 % en nueve meses) [4, 17]. Carelon Services vende servicios de gestión de especialidades y de pagos que la IA puede abaratar a sus clientes o a sus competidores. El riesgo es regulatorio: el uso de algoritmos para denegar autorizaciones está bajo escrutinio y figura entre los riesgos del 10-Q [5]. Señal: un ratio de gastos operativos ajustado por debajo del 11 % en 2027.

26. ESG y controversias

Confianza: Media

Asuntos materiales

Lo material son el acceso y el coste de la atención (denegaciones, autorizaciones previas, revisión de terapias conductuales en Medicaid) y la integridad de los datos de riesgo enviados a CMS, que ya costaron 935 M en 2026 [5, 17]. La privacidad de los datos sigue siendo un riesgo: Elevance sufrió en 2015 el mayor robo de datos sanitarios de EE. UU. (78,8 M de personas) [1]. No hay riesgo climático material en las cifras.

Controversias

Aviso de CMS de febrero de 2026 sobre diagnósticos de Medicare Advantage de 2015-2023: provisión de 935 M, 342 M pagados el 27-may-2026 y caso cerrado sin sanciones el 13-jul-2026 [5]. Demanda del Departamento de Justicia por la Ley de Reclamaciones Falsas (datos de riesgo de la parte C), en fase de pruebas hasta 2027 [5]. Demanda colectiva de valores por la guía de 2024, que sigue adelante tras la decisión de septiembre de 2026 [5]. Robo de datos de 2015 (78,8 M de personas) [1].

27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

Confianza: Media

#	Tema	Pregunta	Por qué importa
1	**Renta de inversiones**	¿Qué parte exacta de la renta de inversiones de 2026 son ajustes de valoración no recurrentes y cuál es la renta normal esperada para 2027?	La renta de inversiones del 3T26 fue de 1.037 M frente a 625 M un año antes; casi un tercio del BPA del trimestre fue no operativo.
2	**Medicaid**	¿Qué margen de Medicaid se espera en 2027 con los requisitos de trabajo y las tarifas estatales ya firmadas?	2026 es el «suelo» según la dirección; el objetivo es el 2-4 % y de él depende la mitad de la recuperación del margen.
3	**Reservas**	¿Por qué bajan los días de reservas y cuánto desarrollo favorable de años anteriores incluye el ratio del 3T26?	Un ratio de prestaciones mejorado con reservas no es repetible.
4	**Departamento de Justicia**	¿Qué exposición estima la empresa en la demanda por datos de riesgo de la parte C y en qué se diferencia del caso que cerró CMS?	Es el mayor riesgo legal abierto y no está cuantificado.
5	**Carelon**	¿Qué rendimiento sobre el capital dan Paragon y CareBridge tras dos años, y cuánto crece Carelon Services con clientes externos?	El ROIC incremental de 2021-2025 (6,3 %) está por debajo del WACC.
6	**Caja de la matriz**	¿Cuántos dividendos esperan de las filiales reguladas en 2027 y cuánto de la autorización de 5.007 M se usará?	La caja de libre uso es de 2.416 M; recompras y dividendos dependen de ella.

28. Sentimiento en foros y comentarios

Confianza: Media

Tono: Dividido · **Tendencia:** Mejora

Dónde	Fecha	Comentarios	Tono	Qué se dice
Seeking Alpha (análisis de autores)	2026-10	3	Negativo	Los tres análisis desde julio no recomiendan comprar: el del 21-oct reconoce mejores resultados pero «no suficientes para comprar» y el del 19-oct no ve valor a este precio; en julio, «potencial, pero aún no es compra» [77].
Seeking Alpha (noticias del valor)	2026-10	20	Neutro	Los titulares de agosto a octubre mezclan buenas noticias propias (guía subida, encuesta de UBS a empleadores que pone a Elevance primera) con regulación adversa: bajas en el ACA, transparencia de precios y primas de Medicare Advantage que bajan en 2027 [77].
Stocktwits	2026-10	30	Dividido	Mensajes sobre todo informativos alrededor de los resultados; pocos marcados (3 alcistas, ningún bajista). Se celebra que el coste de Medicare Advantage está bajo control, pero se señala que la mejora vino de la renta de inversiones, la caída del final del 21-oct y la venta de acciones del director financiero [78].
SentiSense (Reddit, X, noticias y YouTube)	2026-10	30	Positivo	Tono «ligeramente alcista» a 30 días pero enfriándose: alcista en noticias y X, neutro en Reddit y YouTube; el tema principal es que la mayor parte del batido de BPA fue no operativo [79].

Tema	Postura	Peso	Qué dicen los datos
Calidad del batido del 3T26	Bajista	Alto	Con razón: el BPA ajustado de 6,99 USD incluye ganancias no operativas netas de 1,85 USD (valoración de inversiones); sin ellas habría sido ≈ 5,14 USD, aún por encima del consenso de 4,71 USD. El informe trata esa renta como no recurrente en 2026.
El coste médico de Medicare Advantage está bajo control	Alcista	Alto	Las cifras lo apoyan: el ratio de prestaciones bajó 70 pb al 90,6 % y la dirección habla de tendencia «elevada pero estable», como UnitedHealth una semana antes. Medicaid sigue siendo el punto débil (2026 es el suelo de margen).
Precio ya en máximos de 52 semanas	Bajista	Medio	Razonable: la acción sube un 27 % en el año y cotiza a ≈ 14,5 veces el BPA ajustado de 2027e, en línea con su mediana de cinco años; el descuento que veían los inversores de valor en primavera ya no existe.
Venta del director financiero (22-oct)	Bajista	Bajo	Venta de 4,66 M USD sin plan 10b5-1 un día después de subir la guía; es su primera venta relevante y en julio la consejera delegada y el presidente compraron. Señal débil: en el contexto de la cotización se registra como «no cambia».
Regulación: ACA, Medicaid y primas de Medicare Advantage 2027	Bajista	Medio	Riesgo real y recogido en el informe: la ley H.R. 1 y el fin de los subsidios del ACA restan afiliados en 2027, y Elevance lo compensa con salidas de mercados y precios.

El sentimiento no es extremo y sigue por detrás de los analistas. Los particulares y los autores de Seeking Alpha reconocen la mejora del coste médico pero dudan de la calidad del batido (casi un tercio del BPA del trimestre fue renta de inversiones no operativa) y de comprar en máximos de 52 semanas. Los analistas, en cambio, subieron objetivos el 22-23 de octubre (UBS a 523, TD Cowen a 495, Guggenheim a 485, Morgan Stanley a 449, RBC a 455; Baird a 406 con «neutral») [50]. Nada de lo que se lee añade un riesgo que el informe no tenga; refuerza dos cautelas: no capitalizar la renta de inversiones de 2026 y no pagar por la recuperación de 2027 antes de verla en los márgenes de Medicaid.

Opiniones de inversores en foros, redes y comentarios de prensa: sirven para saber qué preocupa o entusiasma al mercado, no como fuente de cifras. No entran en la valoración.

Anexos

A. Controles de calidad del análisis

19 de 19 controles correctos. Fuentes: 79 (52 primarias); citas distintas en el texto: 70.

Control	Resultado	Detalle
Geografías suman 100 %	OK	–
DCF inverso calculable	OK	–
Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF	OK	–
Veredicto de sostenibilidad del analista coherente con las pruebas del motor	OK	El analista dice «En parte» y las pruebas del motor dan «Sí»: razónalo en la justificación.
Circulante del primer año de proyección ≈ último real	OK	Supuesto 7,2 % frente a 7,2 % real: genera una variación de circulante de 91 M en el primer año. Converge de forma gradual.
Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa	OK	72 %.
Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %	OK	3,00 %.
Probabilidades de los escenarios suman 100	OK	–
Al menos 5 comparables	OK	8 comparables.
Pesos de la síntesis suman 100	OK	–
Crecimiento del BPA base ≤ 25 % anual desde el último real	OK	–
Precio del cierre de la fecha de corte (o de las dos sesiones anteriores)	OK	–
Recomendación coherente con la regla de decisión	OK	–
La síntesis explica la convicción	OK	La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría.
Capitalización calculada ≈ publicada	OK	–
Al menos 25 fuentes	OK	79 fuentes (52 primarias).
Al menos 10 fuentes primarias	OK	52.
Toda cita [n] existe en fuentes	OK	–
Fuentes sin citar ≤ 15 %	OK	Sin citar: 3, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 47, 57.

Tipo de fuente	Número
Primaria	52
Datos de mercado	12
Prensa	1
Sectorial	7
Analistas	4
Foros y redes	3

B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
balance	rating	Complemento	1) 10-K 2025 (solo habla de los ratings en los riesgos, sin notas); 2) 10-Q del 3T26 (sin notas); 3) folleto de emisión no consultado por tiempo	Omitido
balance	vida_media_anios	Complemento	1) nota de deuda del 10-K 2025 (solo vencimientos); 2) 10-Q del 3T26; 3) derivarla exige el detalle bono a bono	Omitido
capital	adquisiciones.ev_ebitda	Complemento	1) nota de combinaciones de negocios del 10-K 2025 y 2023 (sin EBITDA); 2) comunicados de cada compra (importes no publicados); 3) prensa (sin múltiplos fiables)	Omitido
esg	calificaciones	Complemento	1) web de Sustainalytics no accesible; 2) búsqueda MSCI ESG Elevance; 3) informe de sostenibilidad no accesible	Omitido
gobierno	consejo.desde (R. Kerry Clark)	Complemento	1) proxy 2026 (su ficha ya no figura: se jubila); 2) proxy 2025 no descargado; 3) 10-K 2025 (no lo dice)	Omitido
consenso	estimaciones 2028e BPA ajustado	Complemento	1) Stock Analysis (solo dos años de BPA); 2) MarketScreener (BPA contable); 3) MarketBeat (solo año en curso y siguiente)	Omitido
comparables	ev_ebitda_ntm	Complemento	1) Stock Analysis (solo LTM); 2) MarketScreener de cada comparable (EV con la caja regulada restada); 3) consenso de EBITDA por empresa no disponible gratis con la misma definición	Omitido
sentimiento	Hilos de Reddit leídos directamente	Complemento	1) reddit.com/search.json (bloqueado desde la nube); 2) búsqueda web de hilos sobre el 3T26 (sin resultados del mes); 3) agregado de SentiSense (Reddit neutro a 30 días)	Calculado y marcado como estimación

Fuentes

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
1	Elevance Health, informe anual 10-K 2025	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	6 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000013/elv-20251231.htm
2	Elevance Health, informe anual 10-K 2023 (2021-2022 reexpresados por LDTI)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	21 feb 2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603924000015/elv-20231231.htm
3	Elevance Health, informe anual 10-K 2022	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	15 feb 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603923000007/elv-20221231.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
4	Elevance Health Reports Third Quarter 2026 Results; Raises Full-Year Guidance (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	21 oct 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000068/a3q2026elvearningsrelease.htm
5	Elevance Health, informe trimestral 10-Q del 3T26	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	21 oct 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000071/elv-20260930.htm
6	Elevance Health, resultados del 2T26 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	15 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000058/a2q2026elvearningsrelease.htm
7	Elevance Health, resultados del 1T26 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	22 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000039/a1q2026elvearningsrelease.htm
8	Elevance Health, resultados del 4T25 y del año 2025 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	28 ene 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000006/a4q2025elvearningsrelease.htm
9	Elevance Health, resultados del 3T25 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	21 oct 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000119312525244191/d270615dex991.htm
10	Elevance Health, resultados del 2T25 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	17 jul 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603925000111/a2q2025elvearningsrelease.htm
11	Elevance Health, resultados del 1T25 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	22 abr 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603925000056/a1q2025elvearningsrelease.htm
12	Elevance Health, resultados del 4T24 y del año 2024 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	23 ene 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603925000007/a4q2024elvearningsrelease.htm
13	Elevance Health, resultados del 4T23 y del año 2023 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	24 ene 2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000119312524013498/d736006dex991.htm
14	Elevance Health, resultados del 4T22 y del año 2022 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	25 ene 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000119312523014676/d418386dex991.htm
15	Anthem, resultados del 4T21 y del año 2021 (8-K, exhibit 99.1)	Anthem (SEC EDGAR)	Primaria	26 ene 2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000119312522017585/d279540dex991.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
16	Anthem, resultados del 4T20 y del año 2020 (8-K, exhibit 99.1)	Anthem (SEC EDGAR)	Primaria	27 ene 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000119312521018334/d100984dex991.htm
17	Elevance Health (ELV) Q3 2026 Earnings Call Transcript	The Motley Fool	Primaria	21 oct 2026	https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/10/21/elevance-elv-q3-2026-earnings-call-transcript/
18	Elevance Health (ELV) Q2 2026 Earnings Call Transcript	The Motley Fool	Primaria	15 jul 2026	https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/07/15/elevance-health-elv-q2-2026-earnings-call-transcript/
19	Elevance Health (ELV) earnings history: consensus estimate vs reported EPS	MarketBeat	Datos de mercado	26 oct 2026	https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/ELV/earnings/
20	Elevance Health Tops Earnings Expectations and Lifts Guidance (Dow Jones, con el consenso de FactSet)	Dow Jones vía Tiger Brokers	Prensa	21 oct 2026	https://www.itiger.com/news/2677986627
21	Elevance Health: hechos XBRL (companyfacts)	SEC EDGAR	Primaria	26 oct 2026	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001156039.json
22	UnitedHealth Group, informe anual 10-K 2025	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	2 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000062/unh-20251231.htm
23	UnitedHealth Group, informe trimestral 10-Q del 2T26	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	10 ago 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000197/unh-20260630.htm
24	NHE Fact Sheet (National Health Expenditures 2024)	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	jun 2026	https://www.cms.gov/data-research/statistics-trends-and-reports/national-health-expenditure-data/nhe-fact-sheet
25	National Health Expenditure Projections 2025-2034: Forecast Summary	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	24 jun 2026	https://www.cms.gov/files/document/nhe-projections-forecast-summary.pdf
26	NHE Projections 2025-2034, Table 1: National Health Expenditures and Selected Economic Indicators	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	24 jun 2026	https://www.cms.gov/files/zip/nhe-projections-tables.zip
27	Medicare Advantage in 2026: Enrollment Update and Key Trends	KFF	Sectorial	5 jun 2026	https://www.kff.org/medicare/medicare-advantage-in-2026-enrollment-update-and-key-trends/
28	The Cigna Group, informe anual 10-K 2025	The Cigna Group (SEC)	Primaria	26 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1739940/000173994026000006/ci-20251231.htm
29	CVS Health, informe anual 10-K 2025	CVS Health (SEC)	Primaria	10 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000006480326000010/cvs-20251231.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
30	Humana, informe anual 10-K 2025	Humana (SEC)	Primaria	19 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49071/000004907126000009/hum-20251231.htm
31	Centene, informe anual 10-K 2025	Centene (SEC)	Primaria	17 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071739/000107173926000049/cnc-20251231.htm
32	Molina Healthcare, informe anual 10-K 2025	Molina Healthcare (SEC)	Primaria	10 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1179929/000117992926000005/moh-20251231.htm
33	2027 Medicare Advantage and Part D Rate Announcement (fact sheet)	CMS	Primaria	6 abr 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2027-medicare-advantage-part-d-rate-announcement
34	2027 Medicare Advantage and Part D Advance Notice (fact sheet)	CMS	Primaria	26 ene 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2027-medicare-advantage-part-d-advance-notice
35	2026 Medicare Advantage and Part D Rate Announcement (fact sheet)	CMS	Primaria	7 abr 2025	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2026-medicare-advantage-part-d-rate-announcement
36	The Top Pharmacy Benefit Managers of 2025	Drug Channels Institute	Sectorial	30 mar 2026	https://www.drugchannels.net/2026/03/the-top-pharmacy-benefit-managers-of.html
37	Competition in Health Insurance: A Comprehensive Study of U.S. Markets (actualización 2025, datos 2024)	American Medical Association	Sectorial	dic 2025	https://www.ama-assn.org/system/files/competition-health-insurance-us-markets.pdf
38	Chairman Guthrie Celebrates Long-Awaited PBM Reform Being Signed into Law	Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU.	Primaria	5 feb 2026	https://republicans-energycommerce.house.gov/posts/chairman-guthrie-celebrates-long-awaited-pbm-reform-being-signed-into-law
39	UnitedHealth Group, nota de prensa de resultados del 2T26	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	16 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000191/earningsrelease2q26_7152.htm
40	Elevance Health, proxy statement (DEF 14A) 2026	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	27 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000031/elv-20260326.htm
41	Elevance Health, 8-K de resultados de la junta de 2026 (item 5.07)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	13 may 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000046/elv-20260513.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
42	Elevance Health, 8-K de resultados de la junta de 2025 (item 5.07)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	14 may 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603925000065/elv-20250514.htm
43	Elevance Health, 8-K de resultados de la junta de 2024 (item 5.07)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	15 may 2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603924000069/axsubmissionofmatterstoavo.htm
44	Elevance Health, Form 4 de consejeros y directivos (26-oct-2025 a 26-oct-2026), resumidos con herramientas/form4.mjs	SEC EDGAR	Primaria	26 oct 2026	https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001156039&type=4&dateb=&owner=include&count=40
45	Elevance Health, 8-K del 26-feb-2026 (item 5.02: salida de Peter Haytaian de Carelon; guía reafirmada)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	26 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000019/elv-20260226.htm
46	Elevance Health, 8-K del 2-mar-2026 (item 8.01: aviso de sanciones de CMS en Medicare Advantage)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	2 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000022/elv-20260302.htm
47	Elevance Health, 8-K del 10-sep-2026 (item 7.01: guía de 2026 reafirmada)	Elevance Health (SEC EDGAR)	Primaria	10 sep 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000063/elv-20260910.htm
48	Elevance Health (ELV), CI, CVS, HUM, CNC, MOH, OSCR, ALHC, UNH, SPY y XLV: históricos diarios (herramientas/bolsa.mjs)	Yahoo Finance	Datos de mercado	23 oct 2026	https://finance.yahoo.com/quote/ELV/history
49	Elevance Health (ELV) Stock Forecast & Analyst Price Targets (S&P Global, 22 analistas)	Stock Analysis	Analistas	26 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/forecast/
50	Elevance Health (ELV) Stock Forecast and Price Target (23 analistas)	MarketBeat	Analistas	26 oct 2026	https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/ELV/forecast/
51	Elevance Health, Inc.: valoración y estimaciones 2024-2028	MarketScreener	Analistas	23 oct 2026	https://uk.marketscreener.com/quote/stock/ELEVANCE-HEALTH-INC-18740543/valuation/
52	Elevance Health (ELV) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/statistics/
53	UnitedHealth Group (UNH) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/unh/statistics/
54	The Cigna Group (CI) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ci/statistics/
55	CVS Health (CVS) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cvs/statistics/
56	Humana (HUM) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/hum/statistics/
57	Centene (CNC) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cnc/statistics/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
58	Molina Healthcare (MOH) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/moh/statistics/
59	Oscar Health (OSCR) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/oscr/statistics/
60	Alignment Healthcare (ALHC) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	23 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/alhc/statistics/
61	Daily Treasury Par Yield Curve Rates 2026 (10 años: 5,00 % el 23-oct-2026)	U.S. Department of the Treasury	Primaria	23 oct 2026	https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026
62	Implied ERP by month (ERPbymonth.xlsx), octubre de 2026: 4,20 %	Aswath Damodaran, NYU Stern	Datos de mercado	oct 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx
63	Betas by Sector (US), enero de 2026	Aswath Damodaran, NYU Stern	Sectorial	ene 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
64	Informe de UnitedHealth del 18-oct-2026 (comparables: crecimiento, margen y deuda de cada aseguradora de sus 10-K y del consenso)	Repositorio propio (informes/unitedhealth-2026-10-18)	Analistas	18 oct 2026	informes/unitedhealth-2026-10-18/datos.json
65	Cigna to Acquire Express Scripts (exhibit 99.1 del 8-K)	Cigna / SEC	Primaria	8 mar 2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/701221/000095015918000059/ex99-1.htm
66	CVS Health to Acquire Aetna (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	4 dic 2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000119312517359526/d482402dex991.htm
67	OptumInsight and Change Healthcare Combine (exhibit 99.1 del 8-K)	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	6 ene 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000119312521002419/d60247dex991.htm
68	Amedisys and Optum to Combine (exhibit 99.1 del 8-K)	Amedisys / SEC	Primaria	26 jun 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/896262/000110465923074547/tm2319648d1_ex99-1.htm
69	CVS Health to Acquire Signify Health (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	6 sep 2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000119312522238311/d344935dex991.htm
70	Express Scripts Holding, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	feb 2018	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001532063.json
71	Aetna, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	feb 2018	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001122304.json
72	Change Healthcare, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	may 2021	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001756497.json

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
73	Amedisys, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	may 2023	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000896262.json
74	Signify Health, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	mar 2022	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001828182.json
75	CVS Health to Acquire Oak Street Health (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	8 feb 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000094787123000133/ss1747225_ex9901.htm
76	Humana to acquire remaining interest in Kindred at Home (exhibit 99.3 del 8-K)	Humana / SEC	Primaria	28 abr 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49071/000004907121000079/exhibit993kindredathome-.htm
77	Elevance Health: Better Results, But Not Enough To Buy; Why I Don't Believe In The Stock At This Price; Has Upside, But Not Yet A Buy (análisis de autores externos, titulares y entradillas del RSS)	Seeking Alpha	Foros y redes	21 oct 2026	https://seekingalpha.com/api/sa/combined/ELV.xml
78	ELV: flujo de mensajes (30 mensajes, 8 a 24 de octubre de 2026)	Stocktwits	Foros y redes	24 oct 2026	https://stocktwits.com/symbol/ELV
79	Elevance Health, Inc. (ELV) Sentiment: Bullish or Bearish? (30 días: noticias, X, Reddit y YouTube)	SentiSense	Foros y redes	26 oct 2026	https://app.sentisense.ai/stocks/ELV/sentiment

Control de calidad del informe

Campos con dato: **93,2 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **ninguna** · Generado el 26 oct 2026.

Iteración del informe del 14-oct-2026 tras los resultados del 3T26 (21-oct-2026); todos los datos se han vuelto a comprobar con el 10-Q, la nota de prensa y la conferencia del 3T26 y con el XBRL de la SEC. Precio de cierre del viernes 23-oct-2026 (la sesión del lunes 26 no había cerrado). Cuenta de resultados en formato por función: EBIT = ingresos − prestaciones − coste de productos − gastos operativos + renta de inversiones − amortización de intangibles; los resultados de instrumentos financieros, los intereses y la amortización anticipada de deuda van al resultado financiero. Criterio de flotante (como en UnitedHealth): el EBITDA incluye la renta de las inversiones de las filiales reguladas, así que el puente solo cuenta la caja de la matriz (2.416 M a 30-sep-2026), las reservas médicas quedan fuera del circulante y el capital estatutario que exige el crecimiento se suma al capex del DCF. El BPA de los escenarios a 12 meses y la historia del PER usan el BPA ajustado publicado por la empresa (sin amortización de intangibles ni partidas no recurrentes); el informe del 14-oct mezclaba una historia sobre el BPA contable con casos sobre el ajustado. 2021 y 2022 están reexpresados por la norma LDTI en el 10-K 2023. Los comparables usan el PER: el valor empresa de Stock Analysis resta la caja regulada.

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.